

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

רפואת המשפחה

13.06.23

מס' השאלות בחלק זה: 150

יש לענות את התשובה הנכונה ביותר

1. בן 73, ברקע - ממוחלת לב איסכמית, יציב, עם היענות טובה לטיפול תרופתי. מבצע הליכה של 2 ק"מ כל יום, ללא קוצר נשימה. באקו לב שבוצע תוך מעקב שיגרת: ממצא חדש של היצרות קלה של מסתם אאורטאלי, מפל לחצים בין החדר השמאלי לאאורטה מוגבר מעט, 55% Ejection fraction. מה הטיפול המתאים ביותר בשלב זה?

- א. ניתוח לתקון המסתם בהקדם.
- ב. המשך טיפול תרופתי נוכחי.
- ג. הדרכה לגבי הגבלה של פעילות גופנית.
- ד. הגברת טיפול תרופתי להורדת preload.

2. מטופלת בת 32 מתלוננת על רעד. מה יתמוך באבחנה של ESSENTIAL TREMOR?

- א. הרעד התחיל באופן פתאומי בימים האחרונים.
- ב. הרעד מחמיר בשתיית אלכוהול.
- ג. אבא של המטופלת סובל מרעד בראש.
- ד. הרעד מופיע בעיקר כשהידיים במנוחה ומונחות על השולחן.

3. למי מהמטופלים הבאים יש המלצה לבצע סקר לאנמיה?

- א. בת 45, מתלוננת על בחילה, רמת קראטינין 2.5 מ"ג/ד"ל.
- ב. בן 50, ירידה בתפקוד מיני, רמת טסטוסטרון נמוכה.
- ג. בת 30, בריאה, מעוניינת לבצע "בדיקות כלליות".
- ד. בת 50, ברקע אוסטאופורוזיס, תלונות על עצירות, רמת סידן 11 מ"ג%.

4. בת 60, מגדלת חתולים בביתה. פנתה עקב הגדלת קשרית לימפה על-בריחית (supraclavicular) של 2 ס"מ מזה חודשיים.

מהי הפעולה הנכונה ביותר בבירור תלונתה?

א. בחשד סביר ל-CAT SCRATCH DISEASE יש לבצע FNA.

ב. עקב גילה ומשך המחלה יש לבצע ביופסיה פתוחה.

ג. יש לטפל אמפירית בדוקסילין (Doxycycline) ל-10 ימים.

ד. בממצא בגודל זה מומלץ לבצע מעקב פעיל עד 3 חודשים.

5. איזו אנטיביוטיקה מניעתית נמצאה כמפחיתה החמרות בחולי COPD על פי סקירה שיטתית (Systematic Review)?

א. Augmentin (Amoxycillin Clavulanate)

ב. Tavanic (Levofloxacin)

ג. Dalacin (Clindamycin)

ד. Azenil (Azithromycin)

6. מה מהמאפיינים הבאים מתאים לאבחנה של Migraine Headache?

א. כאב ראש שמופיע מעל 15 ימים בחודש.

ב. תלונות של aura מקדימות את כאב הראש בשעה.

ג. קיימת החמרה של הסימפטומים במהלך הריון.

ד. מרבית המקרים מופיעים בנשים לקראת המנופאוזה.

7. בת 29, בריאה ברקע, ללא רגישות לתרופות ידועה. ילדה לפני כחודשיים, מיניקה. פנתה עקב חום 38.5, כאב, נפיחות ואודם בשד ימני מזה יומיים. בבדיקה – אודם, נפיחות, חום מקומי ורגישות במישוש בשד ימין. מה הטיפול המומלץ?

- א. NSAIDs והימנעות מהנקה.
- ב. לשאוב ולזרוק את החלב הנשאב משד ימין.
- ג. המשך הנקה בשתי השדיים ומתן Cephalixin.
- ד. קומפרסים חמים לפני הנקה ומתן Clindamycin.

8. בן 56, ברקע יתר לחץ דם לא מאוזן. מתאמן פעמיים בשבוע בריצה. איזה אימון כוח מומלץ להוסיף במצבו?

- א. אימוני כוח 2-3 בשבוע עם רווח של לפחות 48 ש' זה מזה.
- ב. לשלב עבודה איזומטרית באימוני הכוח.
- ג. לשלב תרגילים הכוללים וולסלבה באימוני הכוח.
- ד. במצבו אין להוסיף אימוני כוח.

9. בן 40, מזה יומיים אודם וגירוי בעין ימין מלווה בהפרשה מוגלתית ובבוקר מתקשה לפתוח את העיניים. יש דמעת רבה ללא טשטוש ראייה בבדיקתו - אודם דיפוזי בלחמית ימין בלבד. מהו הטיפול המתאים ביותר למצב זה?

- א. Col. Livostin
- ב. Col. Phenimixin
- ג. Col. Lyteers
- ד. Col. Cosopt

10. בן 6, מתלונן על כאב ברגליים שהופיע בחודש האחרון. הכאב בשוקיים, מופיע בשעות ערב-לילה, לאחר חוג כדורגל. שולל כאב במפרקים. בבדיקה – הליכה תקינה, ללא חום/אודם/נפיחות או תפרחת בגפיים. מה מאפיין את הבעיה הרפואית המוצגת?

- א. הכאב יכול להמשך יותר מ-24 שעות.
- ב. הכאב יכול להופיע גם בגפיים העליונות ללא קשר לגפיים תחתונות.
- ג. הכאב מופיע לסירוגין ולא משתנה עם הזמן.
- ד. הכאב אופייני לתקופות של גדילה מהירה.

11. מהו ההסבר למטופל לגביי זכאות לביטוח משלים?

- א. בעת מעבר בין קופ"ח עד 90 יום מהמעבר זכאי מבוטח להצטרף לרובד זהה של ביטוח משלים ללא החרגות והתניות.
- ב. ניתן להציע במסגרת הביטוח המשלים תרופות מצילות חיים לשם הבטחת טיפול בתרופות חדשות שטרם נכנסו לסל השירותים.
- ג. ניתן להתאים את עלות הביטוח למצב רפואי קיים רק בעת ההצטרפות לתוכנית.
- ד. קופ"ח יכולה לשנות את הרכב השירותים בביטוח המשלים מעת לעת כרצונה לשם הענקת שירות מיטבי במגבלת תקציבה.

12. בת 82, ללא מחלות כרוניות, מלינה לאחרונה על ירידה במשקל כ-2 ק"ג בשלושה החודשים האחרונים, ירידה במצב הרוח ותשישות רבה. בבדיקה הגופנית – משקל 56 ק"ג, ללא ממצא חולני. בדיקה נוירולוגית תקינה, מיני מנטל (MMSE) 24/30. מה מגדיר אותה כשברירית (Frail) לפי המודל הפנוטיפי (Phenotypic Model)?

- א. תוצאת מיני מנטל (MMSE).
- ב. ירידה במשקל ב-2 ק"ג.
- ג. התשישות שהמטופלת מלינה עליה.
- ד. ירידת מצב הרוח.

13. אישה בשבוע 9 (+3) להריונה, מתלוננת על בחילה והקאה שהחלו לפני שבועיים והחמירו לאחרונה. בבדיקה – לחץ דם 99/66 מ"מ"כ, דופק 85, חום 36.7 מ"צ, ללא רגישות בטנית וללא סימני גירוי צפקי. שתן בסטיק – משקל סגולי 1.010, ללא קטונים. ניסיון לטפל בשינוי תזונתי ו- OTC המכיל ויטמין B6 וג'נג'ר הביאו לשיפור חלקי בלבד.

מהו הטיפול המומלץ ביותר בשלב זה?

א. מתן נוזלים 0.9% NaCl.

ב. להפנות לדיקור סיני.

ג. מתן Zofran (Ondasetron) עד פעמיים ביום.

ד. להוסיף לטיפול הקיים Doxylamine.

14. בן 11 חודשים, בריא בד"כ ומחוסן כפי גילו. לפני כחודש טופל במוקסיפן עקב דלקת ריאות. כעת הגיע עם חום 39.5 מעלות צלזיוס ואי שקט. בבדיקת האוזניים:



מה הטיפול המתאים ביותר למצבו?

א. Col. Ciloxan (ciprofloxacin) מקומי

ב. Syr. Augmentin פומי.

ג. ניקור עור התוף.

ד. מעקב צמוד.

15. בן 46, נ+3, בבדיקותיו:

Test	Results	Units	Normal range
Glucose	133	Mg/dl	70-100
HbA1C	6	% Total Hb	4-5.7

אילו פרטים נוספים יעזרו בקביעת אבחנה חדשה של סכרת?

- א. כעבור שבוע, חזר על בדיקת Glucose בצום, תוצאת הבדיקה 127.
- ב. בדיקה לא נלקחה בצום.
- ג. כעבור שלושה חודשים, חזר על בדיקת HbA1C, תוצאת הבדיקה 6.3%.
- ד. מדידת סוכר אקראית שביצע במוקד, תוצאת הבדיקה 185.

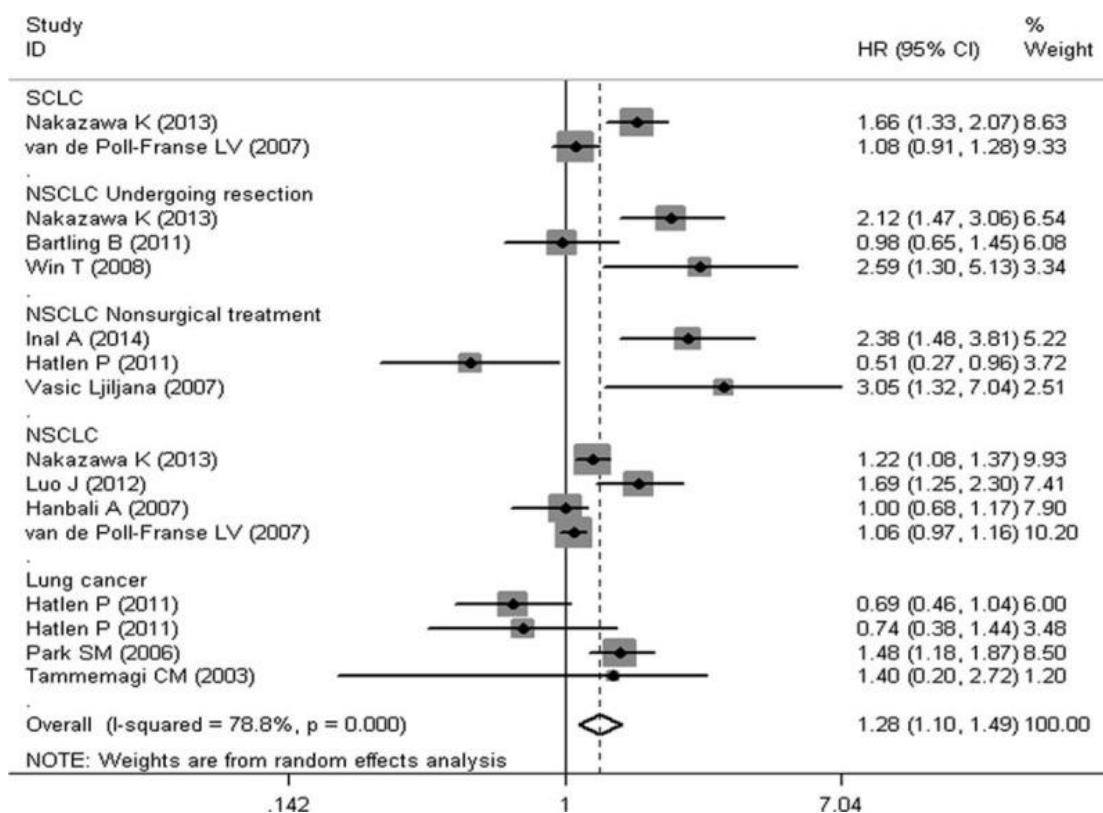
16. בת 21, בריאה. מתארת כי בשנה האחרונה סובלת מכאבי ראש התקפיים, אחת לשבוע, כאב ראש בעוצמה בינונית-חמורה, חד צדדי ופועם. כאב מלווה בבחילות, ואי סבילות לרעשים. לפני חלק מההתקפים יש כחצי שעה שבה מופיעים סחרחורת משמעותית, טנטון וחולשת יד שמאל. התופעה חולפת לחלוטין בטרם הופעת הכאב המוכר.

מהו הטיפול המתאים והיעיל ביותר בעת ההתקף?

- א. Dexamethasone חד פעמי.
- ב. משלב אצטמינופן/אספירין/קפאין.
- ג. טריפטנים בתרסיס אף.
- ד. Deralin (Propranolol).

17. מחקר The Effect of Diabetes Mellitus on Lung Cancer Prognosis: A PRISMA-compliant Meta-analysis of Cohort Studies

בדק השפעת סכרת על הפרוגנוזה של מטופלים עם סרטן ריאה.



מה ניתן להבין מהטבלה המצורפת?

- כל המחקרים שנכללו במטה אנליזה היו עם תוצאות מובהקות ולכן אפשר לסמוך על תוצאות מחקר זה.
- המחקר בעל המשקל הכי גבוה הראה תוצאה מובהקת משמעותית ולכן הסיכום של כל המחקרים ביחד היה מובהק סטטיסטית.
- אי אפשר לסמוך על תוצאות המחקר מכיוון שאין התייחסות ל P-value של כל אחד מהמחקרים שנכללו.
- תשעה מתוך המחקרים שנכללו היה להם HR מובהק סטטיסטית.

18. באילו מהמטופלים הבאים יש חשד ליתר לחץ דם שניוני?

- א. בן 45, לראשונה בחייו לחץ דם של 162/110 מ"מ כספית. ללא סיפור משפחתי של יתר לחץ דם.
- ב. בת 31, מטופלת בגלולות משולבות של אסטרופן ופרוגסטרון מזה 6 שנים. בחודש האחרון מדידות לחץ דם במרפאה 149/87 מ"מ כספית. סיפור משפחתי של יתר לחץ דם אצל אביה ואחיה.
- ג. בת 53, ממוצע מדידות לחץ דם במרפאה 180/90 מ"מ כספית. בבדיקת הולטר לחץ דם נמצא לחץ דם ממוצע בערות של 131/87 מ"מ כספית ובשינה של 124/75 מ"מ כספית.
- ד. בן 32, בבדיקה - BMI 29 ומדידות לחץ דם של 138/96 מ"מ כספית בממוצע מהחודש האחרון.

19. מתי יש לשקול אשפוז במטופל/ת עם Anorexia Nervosa?

- א. זיהום בדרכי השתן.
- ב. משקל הגוף 80% מהמשקל האידיאלי.
- ג. ירידת לחץ דם אורתוסטטית.
- ד. באק"ג סימנים של 1st A-V Block.

20. בת שלוש וחצי שנים, בריאה, לא מחוסנת כלל, ננשכה בידה השמאלית על ידי כלב ביתי מחוסן. בוצעה שטיפה וחיתוי מקומי לפצע המדמם, ללא צורך בהטריה. הכלב נשלח להסגר ולא מראה סימני כלבת. מה הטיפול המומלץ במצבה?

- א. טיפול אנטיביוטי ב-Cephalexin מניעתי.
- ב. חיסון סביל ופעיל לטטנוס.
- ג. טיפול במשחה אנטיביוטית מקומית.
- ד. חיסון פעיל וסביל כנגד כלבת.

21. מי מהמטופלים הבאים יש להפנות כעת לביצוע דופלקס לגילוי מוקדם של Abdominal Aortic Aneurysm?

- א. בת 60, לא מעשנת, מתלוננת על כאבי ברכיים בהליכה.
- ב. בן 45, מעשן מזה 15 שנה, בממוצע קופסה ליום.
- ג. בת 70, מעשנת מזה 50 שנה, בממוצע 10 סגריות ליום.
- ד. בן 65, הפסיק לעשן לפני 20 שנה, עישן חפיסה ליום.

22. בן 55, ברקע - אי ספיקת לב, יתר לחץ דם וגאוט. סובל מאירועים חוזרים של אבנים בדרכי השתן. איזו תרופה ניתן להפסיק על מנת להקטין את הסיכוי לאירועים נוספים של אבנים בדרכי השתן?

- א. Aldactone (Spironolactone)
- ב. Fusid (Furosemide)
- ג. Alloril (Allopurinol)
- ד. Disothiazide

23. בת 55, מטופלת ב-Activelle (Estradiol AS HEMIHYDRATE, Norethisterone AS ACETATE) עקב תסמיני גיל מעבר, סבלה מאירוע ראשון של Biliary colic. בוצע US בטן עליונה: נצפו שתי אבנים בכיס המרה בגודל 1 ס"מ כל אחת, ללא סימני דלקת חדה. מבין הבאים מה ההמלצה הטיפולית הנכונה ביותר?

- א. ניתוח אלקטיבי להסרת כיס המרה.
- ב. טיפול פומי ב-Ursolit (Ursodeoxycholic acid) 3 ל' חודשים.
- ג. הפחתת שומן רווי וכולסטרול בתזונה.
- ד. הפסקת הטיפול ההורמונלי.

24. מי רשאי להסיר חיסיון רפואי ולהעביר מידע רפואי לגוף שלישי (שאינו גורם מטפל) בהעדר הסכמת המטופל/ת?

- א. הרופא המטפל.
- ב. מנהל המוסד הרפואי.
- ג. שופט בבית משפט לצורך הליך משפטי.
- ד. שלושה רופאים בכירים.

25. בת 42, מסאז'סטית במקצועה, מזה כשבועיים סובלת מכאבים בצד הטרלי של שורש כף יד ימין. שוללת חבלה או חום סיסטמי. הכאב מחמיר בזמן עבודתה ומגביל אותה תפקודית ביום יום. מבחן פינקלשטיין (Finkelstein) חיובי. מהו הטיפול המתאים ביותר בשלב זה?

- א. טיפול בסד מתאים ומשכך כאב.
- ב. טיפול פומי בסטרואידים לשבוע.
- ג. ניתוח לשחרור הגיד.
- ד. גבס מלא של האמה עד בסיס האצבעות.

26. בן 5. בריא בדרך כלל. אובחן כסובל מ- Acute Otitis Media. טופל ב-Moxypen (Amoxycillin). כעבור ארבעה ימים החל לסבול מחום 38.5 מעלות צלזיוס והרגשה כללית רעה. בבדיקתו - האוזן בולטת ורגישה בהשוואה לשנייה, הפרשה מוגלתית בתעלה, והשטחת הקמט הנאזו-לביאלי באותו צד. מהו הצעד הבא המתאים ביותר?

- א. מתן Augmentin (Amoxycillin Clavulanate).
- ב. השלמת 10 ימי טיפול ב-Amoxycillin.
- ג. טיפול בטיפות אוזניים אנטיביוטיות.
- ד. הפניה למיון.

27. מהי ההמלצה המתאימה ביותר למטופלת המתלוננת על קשיים בשליטה בשתן?

- א. שימוש בפסרי (pessary) יכול לשפר תסמינים אפיזודיים כגון בזמן פעילות גופנית או בהריון.
- ב. תרגילי קגל (kegel) הם ליבת הטיפול ההתנהגותי באי נקיטת שתן מסוג overflow.
- ג. ניתוח sling מהווה קו טיפול מקובל עבור אי נקיטת שתן מסוג urge.
- ד. טיפול תרופתי אנטימוסקריני מומלץ לשיפור תסמיני אי נקיטת שתן מסוג stress.

28. אמא לשלושה ילדים בגילאים בין 2-12 שנים פונה אליך בנושא המלצה לצפייה במסכים. מהן ההמלצות לפי נייר עמדה של הר"י בנושא של שימוש במסכים בילדים?

- א. ניתן לאפשר לכל אחד מהילדים לצפות בסרטון המותאם לגילו לפני השינה.
- ב. בצפייה במסכים מומלץ להרחיק את המסך מהעיניים ב-30 ס"מ.
- ג. לבן 10 ניתן לאפשר לצפות בטלוויזיה במשך שעותיים רצוף.
- ד. לבן 8 ניתן לאפשר לבצע שיעורי בית כשהטלוויזיה פתוחה ברקע.

29. בן 70, חולה לב הסובל מנזלת ממושכת, נבדק בשל דימום קל מהאף, הדימום החל היום ונמשך מספר דקות לסירוגין.

בבדיקה ההתרשמות היא כי הדימום מאיזור Kiesselbach plexus

איך לטפל בדימום בשלב ראשון?

- א. להשכיבו וללחוץ על הנחיר המדמם עם צמר גפן.
- ב. לטפטף על צמר גפן Xylometazoline (Otrivin) ולהכניס לנחיר.
- ג. להמליץ על טיפול במשאף Fluticasone (Flixonase).
- ד. להכניס טמפון לנחיר למשך 3 ימים.

30. מה מבין הבאים הוא טיפול מתאים ב-Infantile colic?

- א. בתינוקות הניזונים מתחליף מזון לתינוקות החלפה לתחליף על בסיס סויה.
- ב. בתינוקות הניזונים מתחליף מזון לתינוקות - טיפול בפרוביוטיקה מסוג *Lactobacillus reuteri*.
- ג. בתינוקות עם תסמיני colic ו-gastroesophageal reflux או Omeprazole esophagitis הוכח יעיל בהפחתת בכי.
- ד. הרגעה וחינוך ההורים לגבי מהלך שפיר וחולף.

31. באיזה מהמצבים הבאים ניתן לקבל אישור של ועדת האתיקה?

- א. לחייב אדם לקבל טיפול רפואי קבוע למחלה כרונית למרות התנגדותו.
- ב. לאפשר למטופל עם מחלה קשה לקבל חוות דעת שנייה על ידי המוסד המטפל.
- ג. לסרב למסור למטופל את תיקו הרפואי כשקיים חשש שהמידע בתיק יביא לנזק גופני או נפשי.
- ד. לאפשר למטופל להימנע מדיווח על מחלה מדבקת למשרד הבריאות.

32. בן 50, לפני כשבועיים היה מעורב בתאונת דרכים עם בלימה פתאומית. נבדק בחדר מיון ביום התאונה ושוחרר לאחר שבצילום נשלל ממצא חבלתי. מתלונן על כאבים חזקים בצוואר שלא חולפים מאז התאונה. בבדיקתו רגישות מעל העורף, מגבלה בתנועות הצוואר. בדיקה נוירולוגית תקינה. מה נכון לגבי הפרוגנוזה של מצבו?

- א. מרבית המטופלים חווים הקלה משמעותית בתוך 6 שבועות מהחבלה.
- ב. במידה וישנה תביעה משפטית ההחלמה עלולה להימשך מעל 6 חודשים.
- ג. יש לבצע MRI בשלב זה על מנת להעריך את חומרת הפגיעה בחוט השדרה.
- ד. שימוש בקולר לקיבוע הצוואר יכול לזרז את ההחלמה.

33. במי מהמטופלים הבאים הפרדות רשתית היא האבחנה הסבירה ביותר?

- א. בת 75, ברקע קוצר ראייה משמעותי, מהבוקר רואה דברים צפים ואורות מנצנצים בעין שמאל.
- ב. בן 48, ברקע סכרת לא מאוזנת, יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית. מספר על ירידה חדה בראייה בעין ימין שהתפתחה תוך דקות.
- ג. בת 22, סובלת מכאבי ראש כרוניים, הבוקר אירוע של 20 דקות בו ראתה אורות מנצנצים, נקודות עיוורות (blind spots) וקווים בצורת זיגזג.
- ד. בן 68, ברקע עישון והיפרלידמיה, מספר על ירידה הדרגתית בראייה, בחודשים האחרונים יש עיוות של קווים ישרים בראייה (Metamorphopsia).

34. מה מאפיין דלקת אוזן חיצונית (Otitis externa) בילדים?

- א. הופעה איטית והדרגתית במהלך של שבוע.
- ב. הכאב מוקל על ידי פתיחת הלסת.
- ג. חומרת הכאב מבטאת את חומרת הדלקת.
- ד. יכולה להיות הפרעת שמיעה הולכתית.

35. בת 40, בבדיקת CT ראש ממצא מקרי של קשרית בבלוטת התריס. אין סיפור של הקרנות לראש-צוואר בעברה. TSH=2.5 וערכים T3, T4 תקינים. ב-US מודגמת קשרית באונה השמאלית בקוטר 18 מ"מ, היפראקואית עם גבולות סדירים, בחלקה ציסטית ובחלקה ספונגיפורמית, ללא הסתיידויות וללא הגדלה של קשרי לימפה צוואריים. מה המשך הבירור?

- א. מיפוי בלוטת התריס עם טכנציום.
- ב. אספירציה (Aspiration) מהממצא.
- ג. US ביקורת בעוד 12-24 חודשים.
- ד. FNA כעת.

36. בן 78, ברקע סכרת מסוג 2, מתלונן על הופעת כאב חד באזור הפרינאום. בבדיקה - חום 39.5 מעלות צלזיוס, דופק 108 פעימות לדקה, לחץ דם 100/60 מ"מ כספית. באזור הפרינאום אודם, נפיחות, רגישות מקומית וקריפיטוס. איזו מהתרופות אותן נוטל לטיפול בסכרת עלולה לגרום למצב זה?

- א. Pioglitazone (Actos)
- ב. Empagliflozin (Jardiance)
- ג. Dulaglutide (Trulicity)
- ד. Repaglinidine (Novonorm)

37. מי מהבאים צריך להמשיך טיפול באנטי-קואגולציה (anticoagulation) מעבר ל-3 חודשים?

- א. גבר בן 30, DVT ב- Posterior Tibial Vein באורך 4 ס"מ ללא סיבה בבירור או גורמי סיכון לדמם.
- ב. בת 27, שבועיים לאחר לידה, DVT ב- Great Saphenous Vein, אירוע ראשון, ללא גורמי סיכון לדמם
- ג. בן 68 עם שחמת הכבד על רקע צריכת אלכוהול, DVT ב- External Iliac Vein ללא סיבה ברורה.
- ד. בת 58, שבוע לאחר ברונכוסקופיה עם ביופסיה מגידול, נמצא DVT ב- Common Femoral Vein, ללא גורמי סיכון לדמם.

38. ניסוי שבדק השפעתה של תרופה חדשה חילק 100 חולים באופן אקראי לקבוצת טיפול בתרופה וקבוצת פלצבו. במהלך הניסוי 10 מטופלים מתו בקבוצה שלקחה את התרופה לעומת 20 בקבוצת הפלצבו. מה מהבאים נכון?

- א. צריך לטפל בחמשה חולים כדי למנוע מקרה מוות אחד.
- ב. הסיכון היחסי לאירוע מוות בקבוצה המטופלת לעומת פלצבו הוא 20%.
- ג. הפחתת הסיכון המוחלטת בין שתי הקבוצות הוא 50%.
- ד. אם ה $P \text{ value} \leq 0.05$ ניתן להגיד בוודאות שהטיפול יעיל.

39. בת 32, היריון שבוע 25. האחות במרפאה מדווחת על ממוצע שלוש מדידות לחץ דם שבוצעו במרפאה של 145/105 מ"מ כספית. בתחילת ההיריון מדידות לחץ הדם נעו סביב 120/80. מהו הטיפול המומלץ ביותר בשלב זה?

א. דיאטה דלת מלח בלבד.

ב. Hydrochlorothiazide.

ג. Ramipril.

ד. Nifedipine.

40. נודע לך על התפרצות אבעבועות רוח (Varicella) בבית ספר של הישוב סמוך למרפאתך. מהי ההמלצה לגבי post exposure prophylaxis אצל המטופלים המשויכים אליך?

א. מתן VZV immune globulin למדוכאי חיסון עד 10 ימים מרגע החשיפה.

ב. מתן חיסון varicella לילדים בריאים לא מחוסנים יעיל בימים 7-10 מהחשיפה.

ג. טיפול מניעתי ב-Acyclovir מומלץ לילדים בריאים לא מחוסנים.

ד. מרגע הופעת שלפוחיות מתן VZV immune globulin מומלץ לכל הילדים.

41. בן 72, ברקע, יל"ד מאוזן. בעברו עישון של 38 שנות קופסא, הפסיק לעשן לפני 8 שנים, בצע בדיקת CT חזה בקרינה נמוכה (LDCT) לגילוי מוקדם של סרטן הריאה, הבדיקה פורשה כתקינה. מהי ההמלצה הנכונה ביותר לגבי המשך המעקב עבורו?

א. בדיקה חוזרת אחת ל-3 שנים בשילוב כיח לציטולוגיה כל שנה.

ב. בדיקה חוזרת כל שנה עד השלמת 15 שנים מהפסקת העישון.

ג. בדיקה חוזרת כל שנה למשך 15 שנים נוספות.

ד. ניתן להסתפק בבדיקה חד פעמית, אין צורך בהמשך המעקב.

42. מי מהמטופלים הבאים עם Paget Disease עשוי להתאים לטיפול ב-Aclasta (Zolendronate)?

א. מטופל עם מחלת כליות כרונית Stage 4, סובל מכאבים חזקים, במעבדה Alkaline Phosphatase 418.

ב. מטופלת עם ירידה הולכתית בשמיעה.

ג. מטופל א-תסמיני, בצילום רנטגן נגע ליטי בגולגולת, ללא תסמינים.

ד. מטופלת א-תסמינית, במיפוי העצמות שלושה נגעים ליטיים ב-Iliac Crest ובצלעות.

43. בת 19 סובלת מגודש אפי ועיטושים מרובים מחמירים לאחר חשיפה לאבק ובעונות המעבר. מהי הגישה הטיפולית המומלצת ביותר?

א. טיפול ב-Otrivin (Oxymetazoline) למשך 3 חודשים או בתחילת עונות מעבר.

ב. עטיפת מזרונים וכריות בציפוי ניילון לא הוכחה כיעילה למרות שעדיין מומלצת.

ג. התקנת מערכת סינון אויר שהוכחה כיעילה.

ד. אימונותרפיה כקו ראשון גם בביטוי קל של המחלה.

44. בת 56, לפני חודשיים עברה אירוע מוחי, מאז סובלת משיתוק פלג גוף ימני ודיכאון. היא גרה בצפון. בעלה נמצא בקנדה לשנה מטעם עבודתו. שני בנים סטודנטים, גרים במרכז הארץ. המטופלת זקוקה לטיפול סיעודי אך אינה מסכימה להכניס עובד זר. בניה מתחלקים בטיפול בה. מטופלת מצפה שבעלה יתפטר מעבודתו וידאג לה.

כיצד משפיע שלב מחזור החיים של המשפחה על ההתמודדות עם המשבר על פי המודל של רולנד?

א. שלב זה בחיי המשפחה מאופיין באנרגיה צנטריפטלית, אך בשל מצב האם הפכה להיות אנרגיה צנטריפוגאלית

ב. המשפחה תקועה במצב צנטריפוגאלי עקב מצב האם, והיעדרות האב.

ג. מחלת האם הפרוגרסיבית מעצימה את האנרגיה הצנטריפטאלית המאפיינת שלב זה בחיים

ד. המשפחה אמורה להשקיע אנרגיה צנטריפוגאלית בשלב זה, אך כעת עקב המשבר הרפואי האנרגיה חזרה להיות צנטריפטאלית

45. בן שלושה שבועות, בכור להוריו, לאחר הריון ולידה תקינים, בריא עד כה. האם מודאגת מכיוון שהבחינה כי ראשו נוטה לצד אחד. בבדיקתו על גבי שריר הסטרנו-קלאודו-מסטואיד מימין מיששת ממצא מעט נוקשה. מהי ההמלצה המתאימה ביותר?

- א. נדרש ברור הדמיתי טרם התחלת טיפול.
- ב. פיזיותרפיה לתרגול מתיחות של שריר הסטרנו-קלאודו-מסטואיד.
- ג. אין צורך בטיפול או בירור נוסף, מצב שפיר החולף מעצמו.
- ד. ניתוח לשחרור שריר הסטרנו-קלאודו-מסטואיד.

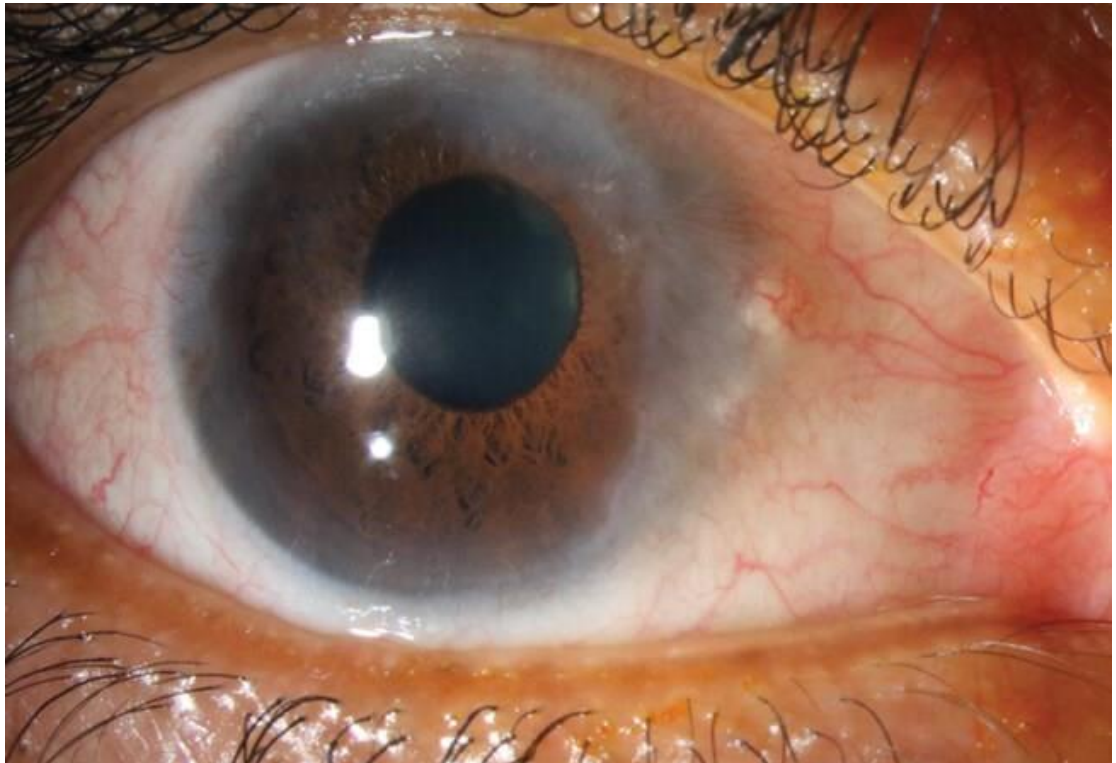
46. בת 48, ברקע – סכרת, יתר לחץ דם, השמנה ועישון. אמה לקתה בסרטן אנדומטריום. מה יפחית את הסיכון של המטופלת לפתח סרטן אנדומטריום?

- א. הפסקת עישון.
- ב. מתן Tamoxifen.
- ג. איזון יתר לחץ דם.
- ד. הכנסת התקן מירנה (Mirena).

47. מחקר השווה את יעילות טיפול באומגה 3 לעומת פלצבו להורדת רמת טריגליצרידים בדם. מטופלים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי. הקבוצה הראשונה קיבלה סטטינים ואומגה 3, הקבוצה השנייה קיבלה סטטינים ופלצבו. המחקר היה כפול סמויות. מה התשובה הנכונה?

- א. שימוש בשיטת ניתוח INTENTION TO TREAT משמרת את הרנדומיזציה ומונעת BIAS.
- ב. שימוש בשיטת ניתוח נתונים PER PROTOCOL מדויקת יותר כי כל מטופל בעת הניתוח הסטטיסטי ישוּך לקבוצה לפי הטיפול שקיבל בפועל.
- ג. מכיוון שמדובר במחקר כפול סמויות אין חשיבות לשיטת הניתוח הסטטיסטי, יתקבלו אותן תוצאות בשתי השיטות.
- ד. חישוב ODDS RATIO במחקר הזה יוכל לעזור בזיהוי יעילות הטיפול באומגה 3 להורדת ערכי טריגליצרידים בדם.

48. בן 34 פנה עקב כאבים טשטוש ראייה ודמעת בעין ימין שהופיעו כשעתיים לאחר פיזור דשן נוזלי. להלן מראה של עינו הימנית:



מהו הטיפול המתאים ביותר?

- א. שטיפות 0.9% NaCl, ומתן טיפול מקומי בסטרואידים.
- ב. שטיפה בהרבה מים והפניה מיידית לרופא עיניים.
- ג. דמעות מלאכותיות בתדירות גבוהה וקומפרסים קרים.
- ד. סגירת העין ושימוש במשחת Synthomycine.

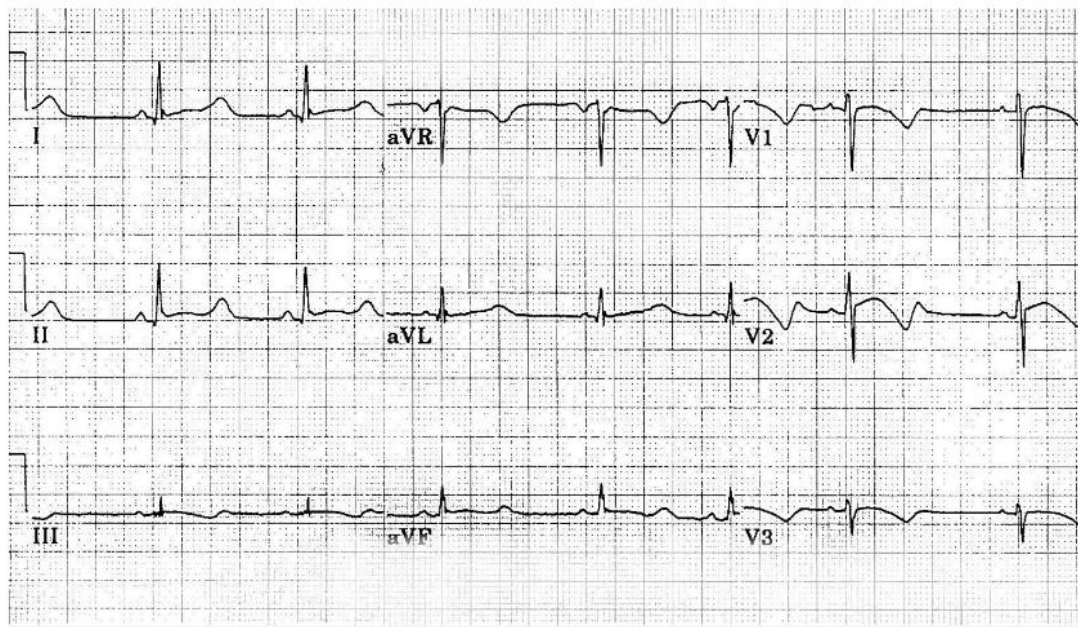
49. בת 13, שחיינית מקצוענית, סבלה בשנה האחרונה מאירועים חוזרים של דלקת אוזן חיצונית. מה הטיפול הטוב ביותר למניעת האירועים החוזרים?

- א. טיפות על בסיס אנטיביוטי לאחר כל שחייה.
- ב. ניקוי יסודי בקיסמי אוזניים לאחר כל שחייה, לייבוש האוזן.
- ג. הזלפת אלכוהול מדולל או תכשירים המכילים Acetic Acid 2%.
- ד. טיפות Otidin או שמן זית לאחר כל שחייה.

50. בת 35 ללא טיפול תרופתי קבוע, החליפה מספר רופאי משפחה בשלוש שנים אחרונות מכיוון שלדבריה "לא הסתדרה איתם והטיפול הרפואי בה הוזנח". חשה ריקנות ובדידות יחד עם התקפי זעם כלפי עמיתה לעבודה והצוות הרפואי במרפאה. בעיון בתיק הרפואי צוין מספר פעמים כי מבטאת מחשבות אובדניות ללא ניסיון אובדני. סובלת מכאבים בחזה מזה 15 שנה, אשר למרות בירור נרחב, לא נמצא מקור ברור או טיפול לכאביה. מספרת כי שמעה שאתה רופא מצוין ובטוחה שתצליח למצוא את הסיבה לכאבים אותם חווה. מהו ניהול הטיפול במצבה?

- א. יש להקפיד על גבולות גמישים ומענה רפואי זמין ומיידי ככל שניתן על מנת לעודד תחושת ביטחון אצל המטופלת.
- ב. יש להקפיד על ביטוי רגשות באופן תדיר על ידי הרופא המטפל על מנת לעודד שיח רגשי עם המטופלת.
- ג. יש להתעלם מאיומי האובדנות של המטופלת ולא לייחס להם חשיבות רבה על מנת להפחית את תדירותם ואת הסיכוי לניסיון אובדני על ידי המטופלת.
- ד. יש להקפיד על שימוש במיומנויות תקשורת כגון ריאיון מוטיבציוני על מנת למתן התנהגויות בעייתיות אצל המטופלת.

51. בן 30, ברקע - תת תריסיות, מטופל ב-Levothyroxin- Eltroxin, ומקבל בימים אלו טיפול להליקובקטר שכולל Tavanic (Levofloxacin) Moxypen (Amoxicillin) ו-Nexium (Esomeprazole). הגיע למרפאה ומספר שהבוקר היה אירוע של איבוד הכרה ראשון בחייו, הרגיש מעט חולשה ואז איבד הכרה. ללא איבוד שליטה על סוגרים או פרכוס, ללא כאבים בחזה וללא תסמינים אחרים. התעורר לאחר מספר שניות. בדיקה גופנית תקינה. ל"ד 110/60 דופק 65, סוכר בגלוקומטר 110. בוצע אק"ג:



מהי ההמלצה בשלב זה?

- א. הפסקת טיפול להליקובקטר.
- ב. העמסת Aspirin.
- ג. השתלת קוצב.
- ד. הפחתת מינון של Eltroxin.

52. מטופל מעד בזמן משחק כדורגל, נחבל בברך שמאל וסובל מכאבים עזים. באילו מהמצבים הבאים יש להפנותו לצילום רנטגן?

- א. גבר מעל גיל 45.
- ב. סבל מכאב בראש הטיביה.
- ג. יכולת לכופף את הברך עד 70 מעלות.
- ד. כאב בעמידה ונשיאת המשקל בעמידה מעל דקה.

53. איזו שאלה מהשאלות הבאות מהווה חלק משאלון PHQ2 לאיתור דכאון בקהילה?

- א. חוסר עניין או חוסר הנאה לעשות דברים.
- ב. הופעה חדשה של עצירות וירידה בתאבון.
- ג. הרגשה רעה כלפי עצמו, מרגיש שהוא כישלון.
- ד. מחשבה שהיה יכול להיות יותר טוב אם הייתי מת/מתאבד.

54. מהי הגישה לגבי הגישה לריבוי תרופות בקשישים?

- א. Beers Criteria הינו רשימת תרופות המועדפות בגיל השלישי.
- ב. ריבוי יועצים מבטיח דיוק באבחנה וצמצום טיפולים מיותרים.
- ג. ההגדרה של Polypharmacy היא שימוש קבוע בחמש תרופות או יותר.
- ד. מערכת ממוחשבת לחידוש תרופות אוטומטי מהווה גורם מגן מפני ריבוי תרופות.

55. בן 51, בריא, ללא מחלות רקע עובר בדיקות בהן נמצא: גלוקוז בצום 105 מ"ג/ד"ל, לחץ דם 138/87. פרופיל שומנים: total cholesterol 200mg/dl, Triglycerides 455mg/dl, HDL 80. מה מהבאים נכון לגבי הסיכון הקרדיווסקולרי של המטופל?

- א. הורדת טריגליצרידים באמצעות פיבראטים תביא לירידה משמעותית בתמותה ובתחלואה.
- ב. יחס סך הכולסטרול ל-HDL מצביע על סיכון נמוך.
- ג. הורדת ה-LDL תביא לירידה ניכרת בסיכון וגם לירידה ב-all-cause mortality.
- ד. פרופיל השומנים מצביע על סיכון גבוה.

56. במי מהבאים יש לבדוק רמת גלוקוז כעת לפי המלצות ADA?

- א. בן 30, אובחן כעת עם HIV ללא בדיקת גלוקוז קודמת.
- ב. בת 29, שנתיים לאחר סוכרת הריונית, גלוקוז בצום 82 לפני שנה.
- ג. בת 45, BMI 24, גלוקוז 98 לפני שנתיים.
- ד. בן 19, BMI 29, ל"ד 125/80, סוכרת אצל הסב, פעיל גופנית.

57. בת 25. יום טרם פנייתה עברה הפלה תרופתית בשבוע 8 להריון (Misoprostol + Mifepristone). מתלוננת על כאבי בטן מלווים בדימום וגינלי וכן הקאות * 3 ושלשול * 3 ביממה החולפת. ל"ד 97/67, דופק 85. מה יש להמליץ למטופלת?

- א. מדידת רמת beta-HCG + אולטרסאונד רחמי למעקב.
- ב. Pramin + Loperamide + Hexakapron
- ג. ספירת דם + תפקודי קרישה באופן דחוף.
- ד. גרידה דחופה.

58. מערכת בינה מלאכותית למדה לאבחן רטינופטיה סוכרתית בעזרת פענוח תמונה דיגיטלית של רשתית העין. ביצועי המערכת נבדקו מול פענוח סטדנרטי של מומחה רשתית. מתוך 1000 מטופלי סוכרת ללא אבחון קודם של רטינופטיה, הצליחה המערכת לסווג נכון כחולי רטינופטיה 180 מטופלים מתוך 200 עם רטינופטיה סוכרתית. כמו כן סיווגה המערכת באופן שגוי כחולי רטינופטיה 200 מתוך 800 מטופלים ללא רטינופטיה. מה המסקנה מנתונים אלה?

- א. רגישות מערכת הבינה המלאכותית הינה 80%.
- ב. סגוליות מערכת הבינה המלאכותית הינה 75%.
- ג. לשכיחות רטינופטיה סוכרתית באוכלוסיית המחקר אין השפעה על ערך המנבא החיובי של המערכת (POSITIVE PREDICTIVE VALUE).
- ד. שיעור החיוביים הכוזבים (FALSE POSITIVE) של המערכת הינו 50%.

59. בת 60, בריאה ברקע, ללא טיפול תרופתי קבוע. סובלת מכאב בטן שמאלית תחתונה. הכאב קבוע באופיו, מלווה בבחילות ירידה בתיאבון. מצינת שלשולים מזה כיומיים, ללא חום סיסטמי, ללא דימום ביציאות. קולונוסקופיה מלפני 5 שנים הדגימה סעיפים במעי היורד. בבדיקה: רגישות בבטן שמאלית תחתונה, ללא סימני גירוי צפקי, נייע ער. מה הטיפול המתאים ביותר במצבה?

- א. אשפוז לטיפול אנטיביוטי דרך הווריד.
- ב. אופיאטים לשיכוך כאבים.
- ג. הנחיה לכלכלה נוזלית ושתייה מרובה.
- ד. מתן Loperamide (Imodium) להקלת השלשול.

60. בן 5 חודשים, בריא ברקע, מזה שבועיים – שיעול יבש התקפי, במגמת החמרה. השיעול גורם להקאה. ללא חום סיסטמי. בדיקת ריאות תקינה. מחוסן לפי גילו. אמו לא קיבלה חיסון Boostrix בשליש השלישי להריונה. מהי בדיקת הבחירה לאבחון של מצבו?

- א. בדיקת PCR במטוש מנזופרינקס.
- ב. תרבית כיח.
- ג. בדיקתה סרולוגית לנוכחות IgM.
- ד. משטח גרון.

61. מהו ההסבר למטופל לגביי הרישום לקופות חולים בישראל?

- א. כל תושב בוגר במדינת ישראל רשאי להירשם לאחת מקופות החולים.
- ב. כל בוגר חייב בביטוח בריאות ויכול לבחור בין קופות החולים לבין מבטח/תאגיד אחר.
- ג. בוגר שלא יירשם לקופת חולים ישוּיך ע"י שר הבריאות לאחת מקופות החולים.
- ד. קופת חולים רשאית להתנות רישום אליה בהסדרת חובות קודמים.

62. מה נכון לגבי הטיפול ב-Systemic Exertion Intolerance Disease (Chronic Fatigue Syndrome)?

- א. טיפול פסיכודינמי הוא הקו הראשון בטיפול.
- ב. הטיפול ב-Myalgia וב-Arthralgia הוא ב-Cymbalta (Duloxetine).
- ג. פעילות גופנית מדורגת (Graded Exercise Therapy) הראתה יעילות טובה יותר מ-CBT.
- ד. גם ללא טיפול שכיח שתסמיני המחלה משתפרים לאחר 12-18 חודשים.

63. בן 50, ברקע – יתר לחץ דם. מתלונן על ירידה בשמיעה שהחלה לפני כ- 3 שבועות. לעיתים מלווה בטינטון.

בבדיקה: במבחן Weber - לטרליזציה לימין, מבחן Rinne חיובי משמאל, שלילי מימין.
מה האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Acoustic neuroma משמאל.
- ב. איבוד שמיעה פתאומי אדיופתי מימין.
- ג. Cholesteatoma משמאל.
- ד. פקק צרומן מימין.

64. בן 8 חודשים, בריא בד"כ, נולד בשבוע 30, ללא סיבוכים. לאחרונה אימו מספרת שכאשר בוכה בזמן החלפת חיתול, נצפה גוש במפשעה, כאשר נרגע הגוש נעלם. יציאות תקינות. בבדיקה, הילד נינוח, במפשעה הימנית ניתן למשש מסה חלקה וקשיחה שגדלה מעט כאשר הילד בוכה. אשכים נמושו בשק. בלחיצה על המסה ניתן להחזיר אותה פנימה.
מה הטיפול המומלץ במקרה זה?

- א. הפניה דחופה לחדר מיון לניתוח מיידי.
- ב. הרמת הרגליים וקירור עם קרח למפשעה.
- ג. הערכת כירורג ילדים בקהילה לצורך ניתוח אלקטיבי בהקדם.
- ד. מדובר במצב שפיר שיחלוף עד גיל 5, בשלב זה מעקב בלבד.

65. בת 45, בריאה ברקע, לא מעשנת, ביצעה צילום חזה לקראת ניתוח אסתטי. בתשובה – קשרית (Nodule) ריאתית בודדת בריאה הימנית.

איזה מבין הנתונים הבאים יגביר ביותר את החשד לממצא ממאיר?

א. מיקום הקשרית בשדה הריאה.

ב. קשרית בקוטר של 10 מ"מ.

ג. הסתיידויות מרכזיות בקשרית.

ד. הקשרית מוגדרת כסולידית.

66. מהי ההתייחסות המתאימה ביותר לגבי טיפול בחתכים נקיים ?

א. בחתכים לא מזוהמים הנגרמים על ידי חפצים נקיים ניתן לבצע סגירה ראשונית עד 18 שעות לאחר הפציעה. ניתן לתקן פצעי ראש עד 24 שעות לאחר הפציעה.

ב. שימוש במי ברז נקיים במקום בסליין סטרילי לשטיפת פצעים מגביר את הסיכון לזיהום.

ג. שימוש בכפפות בדיקה נקיות ולא בכפפות סטריליות במהלך תיקון הפצע מעלה משמעותי את הסיכון לזיהום.

ד. ניתן להשתמש בדבק להדבקת פצעים עד 6 שעות מהפציעה.

67. בת 22, מטופלת בגלולות למניעת הריון. מקיימת יחסי מין מזדמנים.

מתלוננת על הפרשה נרתיקית וכאב בבטן תחתונה שמוחמר בקיום יחסי מין.

מעבדה: בשתן – כדוריות לבנות בלבד, בדיקת בטת HCG שלילית.

מהי הגישה המתאימה ביותר כעת ?

א. להמתין לבדיקת רופא נשים לאבחון וקביעת הטיפול.

ב. לשלוח בדיקת שתן ל-STD ולטפל בהתאם לתשובה.

ג. להתחיל כעת טיפול ב-Doxycycline, Rocephin ו-Metronidazole למשך 7 ימים.

ד. להתחיל כעת טיפול אמפירי ב-Rocephin פעמי ו-Doxycycline ל-14 יום.

68. חברת סטרט אפ פיתחה בדיקה בעלת רגישות וסגוליות גבוהים לזיהוי מחלה מסוימת. בבדיקה חוזרת של האוכלוסייה התגלה כי מדובר במחלה נדירה ושכיחותה נמוכה.

כיצד שכיחות המחלה תשפיע על תוצאות הבדיקה?

- א. תוריד את רגישות הבדיקה.
- ב. תוריד את סגוליות הבדיקה.
- ג. תוריד את הערך החיובי המנבא (PPV) של הבדיקה.
- ד. לא תשפיע כלל על תוצאות הבדיקה.

69. למי מהמקרים הבאים התמותה הנמוכה ביותר?

- א. בן 45, לחצי דם נמדדו במרפאה 131/85 מ"מ כספית ובמידות ביתיות 149/91, ללא טיפול תרופתי.
- ב. בן 45, מדידות לחצי הדם במרפאה 150/95 מ"מ כספית ולאחר תחילת טיפול תרופתי ערכים של 125/75.
- ג. בן 45, בבדיקות במרפאה לחצי דם 157/97 מ"מ כספית ובבדיקות ביתיות מספר פעמים 125/82.
- ד. בן 45, ללא מחלות רקע, ללא טיפול תרופתי, במדידות לחץ דם במרפאה 137/88 מ"מ כספית.

70. מה מהבאים הוא הקו הראשון בטיפול בדום נשימה בשינה (Obstructive Sleep Apnea) בילדים?

- א. סד דנטלי.
- ב. מכשיר Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).
- ג. תרסיס סטרואידים נזאלי.
- ד. הסרת השקדים והאדנואידים.

71. לפניך 4 מטופלים שמתלוננים על חולשה. ספירת דם – המוגלובין 10 ג'/ד"ל. עבור איזה מטופל הבדיקה המוצעת תסייע לאבחון הסיבה הסבירה לבעייתו?

- א. בת 30, מתלוננת על נשירת שיער. MCV 70. תבצע בדיקת G6PD.
- ב. בת 35, ברקע – תת פעילות בלוטת התריס, תלונות על שריפה בלשון. MCV 110. תבצע APCA - Anti-parietal Cell Antibody.
- ג. בן 20, מזה חודש עליית חום סיסטמי לסירוגין, דימום מחניכיים. MCV 90, רמת רטיקולוציטים 0.31%. יבצע בדיקת Ferritin.
- ד. בת 50, טופלה במינוציקלין בגלל Rosacea. MCV 88, רמת רטיקולוציטים גבוהה (5.1%). תבצע קולונוסקופיה.

72. בן 35, בריא ברקע, ללא שימוש קבוע בתרופות. ללא סיפור משפחתי של ממאירות או מחלות מעיים דלקתיות.

מזה כחצי שנה סובל משלשול מימי כמעט על בסיס יומיומי בשעות היום בלבד. שולל כאבי בטן/ריבוי גזים/ירידה במשקל/בחילות או הקאות. השלשול משתפר בימי צום. ללא ממצא חריג בבדיקה הגופנית. בדיקות מעבדה – ספירת דם, בדיקת CRP וסרולוגיה לצליאק – תקינות. מהו הטיפול המתאים ביותר למצבו הנוכחי?

- א. Colotal (Mebeverine HCl).
- ב. טיפול קוגניטיבי התנהגותי.
- ג. Stopit (Loperamide HCl).
- ד. Vancomycin דרך הפה.

73. בת 50, ברקע יתר לחץ דם מאוזן תרופתית, טרום סוכרת. מספרת כי מזה שנה הווסת לא סדירה, וסת אחרונה לפני 9 חודשים. סובלת מגלי חום משמעותיים ומעוניינת לשקול טיפול תרופתי. מהי ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר עבורה?

- א. הטיפול התרופתי היעיל ביותר לגלי חום הוא פרוגסטרון בלי אסטרוגן.
- ב. במידה ואינה מעוניינת בתכשיר הורמונלי, יכולה לקבל טיפול ב-SNRI/SSRI.
- ג. תכשיר המכיל Black Cohosh הראה יעילות גבוהה בטיפול בגלי חום.
- ד. טיפול הורמונלי משולב בטוח למשך 10 שנים, לאחר מכן עולה הסיכון לממאירות שד.

74. אישה בשבוע 10 להריונה, מטופלת עקב יתר לחץ דם כרוני ב-Labetalol (Trandate). ערכי לחץ הדם מאוזנים, ללא חלבון בשתן. מהי ההמלצה להמשך מעקב בהריון?

- א. ביצוע אקו לב עובר.
- ב. ביצוע אקו לב אימהי.
- ג. דיקור מי שפיר.
- ד. מעקב הריון שגרתי.

75. בן 45, ברקע - תסמונת מטאבולית. מטופל ב-Ramipril 5mg*1, Bezofibrate 200mg*1, Micropirin 75mg*1, Metformin 850mg*1, vitamin C*1. מרבה בצריכת קפה. חווה בשנה האחרונה 3 התקפי Gout. ועקב כך החל לפני כשבועיים דיאטה עם הגבלה קלורית של 500 קלוריות ביום. חווה כעת דלקת בברך ימין (Gout Attack). מהו גורם סיכון משמעותי לאירוע זה?

- א. הדיאטה בה החל.
- ב. צריכת vitamin C
- ג. המיקרופירין שצורך
- ד. צריכת הקפה המוגברת.

76. באיזה מהמקרים הבאים יש להפנות את המטופל להערכת שמיעה?

- א. בן 5 חודשים שלא מגיב לקריאה בשמו.
- ב. בן 9 חודשים שלא מצביע על מקור של קול חזק פתאומי.
- ג. בן שנתיים המשתמש במילים בודדות בלבד (פחות מ 10).
- ד. בן 10 חודשים שלא מדבר (אפילו מילה בודדת).

77. בת 28, בריאה בד"כ, הריון ראשון. בבדיקת העמסת סוכר 50 גר' תוצאה של 150 מ"ג/ד"ל. השלימה

העמסת סוכר 100 גר'. תוצאות:

בצום – 90 מ"ג/ד"ל

60 דקות – 210 מ"ג/ד"ל

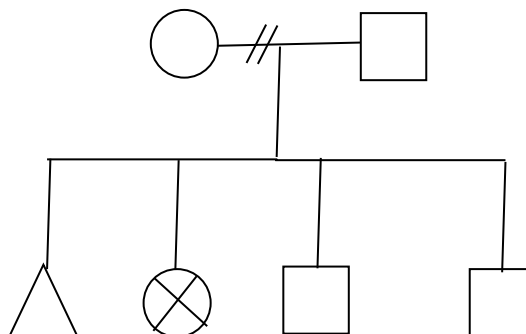
120 דקות – 170 מ"ג/ד"ל

180 דקות – 120 מ"ג/ד"ל.

מה הצעד הבא בניהול המקרה?

- א. להשלים בדיקת HbA1C ולפי התוצאה להחליט על טיפול.
- ב. מעקב בדיקות סוכר בצום ולאחר ארוחה לצורך החלטה על טיפול תרופתי.
- ג. השלמת העמסת סוכר 75 גר' לצורך החלטה על טיפול.
- ד. לחזור על העמסת סוכר 100 גר' שכן התוצאות לא חד משמעיות.

78. מה ניתן להפיק מאילן המשפחה הזה?



- א. זוג הורים פרודים, עם שני בנים ובת, האמא עברה הפלה.
- ב. זוג הורים גרים ביחד לא נשואים, עם שני בנים, ילד עם מחלה גנטית, וילד שנפטר.
- ג. זוג הורים גרושים, עם שני בנים, ילדה שנפטרה, ואמא בהריון.
- ד. זוג הורים גרושים, שני ילדים, ילדה טרנסג'נדרית, ואמא בהריון.

79. בת 43, רצת מרתון. מתלוננת על כאבים ורגישות במישוש בשליש הדיסטלי-קדמי של הטיביה. בבדיקה גופנית ללא ממצא חריג למעט רגישות במיקום הנ"ל.
מה מהבאים הינו הטיפול היעיל ביותר למצבה?

- א. הפסקת ריצה ל-6-8 שבועות
- ב. הימנעות מדריכה עד שהכאב חולף.
- ג. חזרה לפעילות ע"פ סרגל מאמצים מתוכנן, כאב צפוי ולכן לא מכתוב קצב.
- ד. מתיחות של שרירי התאומים מזרזות החלמה.

80. בן 7, מגיע עם הממצא הבא על הקרקפת. בבדיקה יש גם בלוטות לימפה מוגדלות בצוואר.



הותחל טיפול עם התרופה המתאימה לאבחנה הסבירה ביותר.
מה הגישה הטיפולית הנכונה ביותר להמשך הטיפול?

- א. ברגע שעור הקרקפת נראה תקין ניתן להפסיק את הטיפול
- ב. משך הטיפול המקסימלי הוא 6 שבועות
- ג. טיפול למשך חודש לאחר שהמשטח נהיה שלילי מקטין סיכוי לחזרה
- ד. טיפול בשמפו אצל בני המשפחה לא הוכח כיעיל למניעת הדבקה

81. הוקם צוות לכתיבת קווים מנחים לפעולות הנדרשות לאבחון וטיפול במחלה הנקראת תסמונת Z בתרופה הנקראת מג'יק (Magic) - תרופה אותה יש ליטול לאורך כל זמן המחלה.
איזה מהפעולות הבאות מומלץ לנקוט בכתיבת ההנחיות על מנת להימנע מאבחון או טיפול יתר בתסמונת Z על פי נייר העמדה של החברה למניעת טיפול יתר ואבחון יתר מ-2017?

- א. הדגשה של הורדת הסיכון היחסי (relative risk reduction) לסיבוכים מהמחלה במתן טיפול במג'יק ביחס למתן אינבו (placebo).
- ב. שימוש במדדי ביניים (surrogate end points) להוכחת היעילות של הטיפול בתרופה מג'יק.
- ג. המלצה לשימוש בתרופה מג'יק למטופלים קשישים כאשר ידוע שה time to benefit של התרופה ארוך.
- ד. שימוש במדד QALY (Quality-Adjusted Life-Year) להוכחת יעילות ההתערבות הרפואית במחלה.

82. מהי הגישה הטיפולית לתסמונת התעלה הקרפלית (Carpal tunnel syndrome)?

- א. הזרקת סטרואידים יעילה כטיפול לטווח ארוך.
- ב. סד לשורש כף היד (wrist splint) מומלץ לשיפור תסמינים ליליים.
- ג. אטרופיה וחולשה של שרירי בסיס האגודל (thenar) לרוב משתפרים לאחר ניתוח.
- ד. כאשר התסמינים מובהקים, מומלץ טיפול ניתוחי גם אם EMG תקין.

83. מהן זכויות קטין המטופל במערך לבריאות הנפש בישראל?

- א. אשפוז בהסכמת הקטין, מעל גיל 15 אינו דורש הסכמת ההורים.
- ב. קטין שגילו 14 ניתן לאשפוז בהסכמת הוריו, גם בניגוד לרצונו, ולא עומדת לו עילת ערעור.
- ג. קטין שגילו 16 המתנגד לאשפוז למרות הסכמה עליה חתמו הוריו – לא ניתן יהיה לאשפוז.
- ד. הוראת אשפוז לקטין שגילו 17 יכולה להינתן רק לאחר הערכה ע"י מומחה/ית בפסיכיאטריה של הילד.

84. בן 42, ברקע פרפור פרוזדורים, מטופל באליקוויס. מעשן פעיל של 10 שנות קופסא. בבדיקת שתן לכללית אקראית נמצאו RBC/HPF 12. ללא תסמינים אורिनריים.
מה ההמלצה המתאימה ביותר במצבו?

- א. בדיקת שתן חוזרת בעוד 3 חודשים.
- ב. CT Urography
- ג. ציסטוסקופיה.
- ד. שתן לתרבית.

85. למרפאה נכנסת אם מבוהלת נושאת את ביתה בת השנה בזרועותיה ומתארת שבזמן התקף של בכי עקב לקיחת צעצוע הפסיקה לנשום והכחילה. חזרה להתנהג כרגיל תוך כדקה.
איזה מהמצבים קשור עם הסיטואציה המתוארת?

- א. עלייה בסיכון לפתח הפרעות פרכוסיות בעתיד.
- ב. מחסור בברזל לעיתים עד כדי אנמיה.
- ג. קיום נגע במערכת העצבים המרכזית.
- ד. הפרעת קצב קרדיאלית.

86. מה מאפיין טיפול באמצעות deep brain stimulation (DBS) לחולי פרקינסון?

- א. ניתן להציע זאת כטיפול קו ראשון למטופלים צעירים.
- ב. סיבוך אפשרי של הפרוצדורה הוא שבץ מוחי.
- ג. הטיפול משפר תסמיני דיכאון משני למחלת הפרקינסון.
- ד. הטיפול אינו משפר תנודות מוטוריות.

87. בת 26, מניקה תינוק בן 4 חודשים, מועמדת ל-CT עם הזרקת חומר ניגוד. מהי ההנחיה הנכונה ביותר לקראת הבדיקה?

- א. אין צורך להפסיק או לדחות הנקה אחרי CT או MRI עם הזרקת חומר ניגוד.
- ב. ניתן להניק עד הבדיקה אך לאחריה להפסיק הנקה ל-12 שעות.
- ג. יש לשקול לבצע MRI במקום CT על מנת שלא יהיה צורך להפסיק הנקה.
- ד. יש לדחות את הבירור עד לאחר שתסיים להניק.

88. מטופל הסובל מצליעה לסירוגין המגבילה בתפקוד לאחר 50 מטר. נמדד ABI של 0.5. מהו הטיפול המתאים ביותר למצבו?

- א. בחומרה זו יידרש לטיפול התערבותי (ניתוח או צנתור).
- ב. המלצה על עיסוי קבוע לשוקיים.
- ג. פיזיותרפיה לחיזוק שריר הארבע ראשי (Quadriceps).
- ד. המלצה על הליכה עד הופעת כאב משמעותי, לנוח ולחדש את ההליכה.

89. בן 53, ברקע סכרת ויתר לחץ דם, מעשן 20 שנות קופסה.
בחודשים האחרונים הבחין בעיוות עצמים בשדה הראיה, מלווה בטשטוש ראייה בשתי עיניו. לאחרונה אף מציין ירידה בשדה הראיה המרכזי. לדברי רופא העיניים מדובר ב- nonproliferative retinopathy with macular edema.
בבדיקת פונדוסקופיה:



מהו הטיפול המתאים ביותר למטופל בשלב זה?

- א. בשלב זה אין צורך בטיפול. להקפיד על איזון גורמי סיכון קרדיווסקולריים והפסקת עישון.
- ב. נתחיל בטיפול הכולל הזרקות עיניות של anti-VEGF.
- ג. בשלב שבו נמצא מטופל זה, אין כבר טעם באיזון סכרת הדוק, וניתן להיות יותר מתירני מבחינת ערכי ה-A1C.
- ד. טיפול קו ראשון במקרה זה כולל טיפות סטרואידליות.

90. בן שנה, מזה יומיים חום 39 מלווה באי שקט, סירוב לשתות ולאכול, הופעת שלפוחיות בפנים, שפתיים, פצעים בחניכיים ובחייך העליון (מצורפת תמונה).



מה נכון לגבי טיפול תרופתי במצב זה?

- א. מדובר במחלה self-limited, ללא תועלת במתן טיפול תרופתי.
- ב. מחלה נלוות seborrheic dermatitis מחייבת מתן טיפול.
- ג. טיפול תרופתי לא מונע אירועים חוזרים של Erythema multiforme.
- ד. מתן טיפול תרופתי ב-72 שעות הראשונות יכול לקצר את משך המחלה.

91. מה הטיפול המומלץ ב-Polycythemia Vera?

- א. כל המטופלים צריכים לקחת אספירין במינון גבוה (325 מ"ג), בהעדר התווית נגד.
- ב. טיפול בהקזת דם מומלץ לכל המטופלים לשמירה על המטוקריט נמוך מ- 45%.
- ג. Ruxolitinib (Jakavi) הינו טיפול קו ראשון.
- ד. טיפול באנטי היסטמינים לגרד הינו קונטרה אינדיקציה ב-Polycythemia Vera.

92. על פי נייר העמדה לגבי בדיקת נשאות למוטציות BRCA 1/2 מה נכון ביותר?

- א. הבדיקה באינדיקציה לכל חולי/חולות סרטן שד, שחלות ולבלב ממוצא יהודי-אשכנזי בלבד.
- ב. בחולי/חולות סרטן שד שחלה או לבלב - במידה ולא מתגלה אחת המוטציות השכיחות ניתן להניח כי אין רקע תורשתי לתלואה.
- ג. לנשים בריאות שהן נשאיות לאחת המוטציות מומלצת תכנית מעקב ומניעה מוגברת החל מגיל 40 שהוכח שהיא מקטינה סיכון לתלואה ותמותה.
- ד. ממחקרים ביהודים בארץ ובעולם מתברר שלפחות מחצית מהמקרים בהם מתגלה נשאות אצל נבדקים, מדובר באנשים שאין להם סיפור משפחתי משמעותי של ממאירויות.

93. בן 79, ברקע mild cognitive impairment ותת פעילות בלוטת התריס. מטופל ב-Levothyroxine, ערכי TSH בטווח התקין. מתלונן כי מתקשה להירדם בשנה האחרונה ומבלה כשעה במיטה עד שמצליח להירדם.

מהי ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר ?

- א. התחלת טיפול בתרופה מקבוצת Z-drugs.
- ב. הפחתת הזמן בין כניסה למיטה להירדמות בפועל.
- ג. הפחתת טיפול ב-Levothyroxine ומעקב TSH.
- ד. התחלת טיפול ב-Tonight (Doxylamine).

94. בן 50, ברקע - סוכרת. סובל מספר ימים מכאבים עם הגבלה בתנועה של מרפק שמאל. ללא סיפור של חבלה. בבדיקה- המרפק נפוח, יש חום מקומי ורגישות במישוש. ללא חום סיסטמי וללא הגבלה אובייקטיבית בתנועה.

בהתחשב באבחנה המתאימה ביותר מהי הבדיקה שיש לבצע כעת?

- א. ניקור הבורסה.
- ב. צילום המרפק.
- ג. בדיקת דם ל-RF.
- ד. US של המרפק.

95. בן 52, בריא בדור"כ, BMI – 25. מדידות לחץ דם חוזרות במרפאה נעו בין 165/90 לבין 170/94. בבדיקות מעבדה נתרן 141 מא"ק/ל, אשלגן 3.7 מא"ק/ל. לאחר התחלת טיפול בתיאזיד 12.5 מ"ג – ממוצע לח"ד 159/84, נתרן 141 מא"ק/ל, אשלגן 2.7 מא"ק/ל. הופנה למיון וטופל עם אשלגן עד עליית אשלגן ל-3.5 מא"ק/ל.

מה הכי סביר שיתמצא בבירור המעבדתי של מטופל זה?

- א. ממצא של קורטיזול גבוה באיסוף שתן במשך 24 שעות.
- ב. רמות קטאכולמינים בשתן גבוהות באיסוף של 24 שעות.
- ג. יחס אלדוסטרון לרנין בפלסמה גבוה מ-20.
- ד. רמות TSH בפלסמה לא נמדדות.

96. בן שנה וחצי, החל ללכת לפני כחודשיים. האם שמה לב לאחרונה לצליעה אצל הילד ללא כאבים. אין סיפור של תסמינים נלווים כלשהם. בבדיקה צליעה המתבטאת בהטיית הגו לימין בזמן העברת משקל על רגל ימין (Trendelenburg Gait).
מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Occult Trauma
- ב. Transient Synovitis
- ג. Child Abuse
- ד. Developmental Dysplasia of the Hip

97. בת 25, בריאה ברקע, מלינה על גרד נרתיקי מזה כשבוע. שוללת הפרשות חריגות או ריח רע/קשר ליחסים/תפרכת באזור. בבדיקתה – אודם קל שיטחי באזור הפות (vulva).
מהי האבחנה המתאימה ביותר?

- א. Irritant dermatitis
- ב. Atrophic vaginitis
- ג. Bacterial vaginosis
- ד. Tinea Cruris

98. בת 80, עצמאית וצלולה, מגיעה עם הבת לביקור במרפאה, לאחר אשפוז בשל החמרה באי ספיקה לבבית על רקע אי נטילת טיפול תרופתי קבוע. במהלך הביקור נצפות אמירות של כעס, תסכול ו"גלגול עיניים" מצד הבת על אופן התנהלותה של האם והעובדה שאינה מקפידה ליטול את הטיפול התרופתי הקבוע שלה. מהי ההמלצה המתאימה ביותר לערוך את הדיון בביקור הנוכחי?

- א. עקב התנהגות אגרסיבית של הבת יש לבקש ממנה לצאת מהחדר ולהמתין לסוף הביקור.
- ב. להסביר למטופלת את טענות הבת, ולתמוך בטענות הבת כלפי האם
- ג. יש לשקף את הקונפליקט בין הבת והאם ולאפשר דיון פתוח ללא התקפה אישית
- ד. לבקש מהאם להגיע לביקור נוסף ללא הבת כדי לשמוע את הצד שלה.

99. בת 24, מזה כשנתיים סובלת מאפיזודות של בחילות והקאות מרובות (מעל ל-20 ביום) הנמשכות 4-5 ימים, בתדירות של 4-5 פעמים בשנה. בין האפיזודות חשה בטוב. אם ואחיות סובלות ממיגרנות. עברה בירור מקיף - ללא ממצאים חריגים. מהי ההמלצה המתאימה ביותר לטיפול במצבה?

- א. נוגדי דכאון טריציקליים עלולים להחמיר את ההתקפים.
- ב. יש מקום לניסיון טיפולי בטרפטן.
- ג. יש מקום לניסיון טיפולי בקנאביס רפואי.
- ד. טיפול מניעתי בנוגדי בחילה כ-Pramin (Metoclopramide).

100. בן 45 לאחר אירוע לבבי, באקו לב LVEF-45%. הגיע עם הממצאים העוריים הבאים:



מה הגישה הטיפולית הנכונה ביותר להמשך הטיפול?

- א. Oint. Protopic (Tacrolimus)
- ב. S.C Humira (Adalimumab)
- ג. S.C Stelara (Ustekinumab)
- ד. P.O Prednisone

101. בבדיקת מטופל במרפאה, נשקלת אפשרות להפנותו לאשפוז בית. איזה מהמטופלים הבאים מתאים ביותר לאשפוז בית על פי נייר העמדה "אשפוזי בית במתווה תחליף אשפוז בית במחלקות הפנימיות" משנת 2020?

- א. בן 65, מזה יומיים חום ושיעול. בבדיקה הגופנית: נושם 22 נשימות לדקה, דופק 85 פעימות לדקה, לחץ דם 118/75 מ"מ כספית, סטורציה 90% באוויר חדר, בצילום חזה - תסנין בריאה שמאלית עליונה.
- ב. בת 85, סיעודית, מתגוררת עם מטפלת. ברקע COPD, חמצן ביתי (2 ליטר). חום עד 38 מעלות, ללא תסמינים נוספים. בתרבית ליחה - צמיחה של *Pseudomonas* רגיש ל-Ceftriaxone. בבדיקה: דופק 92 פעימות לדקה, לחץ דם 152/85 מ"מ כספית, סטורציה 88% באוויר חדר ו-92% תחת 2 ליטר חמצן.
- ג. בן 74, עם ירידה במשקל של 8 ק"ג בחמישה החודשים האחרונים. בבדיקות מעבדה - עלייה באנזימי כבד ושקיעת דם מוחשת של 70 מ"מ לשעה. ללא חום סיסטמי. המלצת המטופל להמשיך בירור באשפוז בבית החולים אולם המטופל מסרב.
- ד. בת 55, בריאה ברקע, ללא טיפול תרופתי קבוע. פנתה בשל חום וצריבה במתן שתן. מדדים חיוניים: לחץ דם 90/40 מ"מ כספית, דופק 115 פעימות לדקה, חום 39 מעלות צלזיוס וסטורציה 96% באוויר חדר.

102. בן שנה, בריא ומחוסן, מזה ארבעה ימים אינו רגוע, משלשל 5-6 פעמים ביום, הקיא הקאה אחרונה לפני 12 שעות, ביומיים הראשונים נמדד חום 38.2 בבדיקה – חסר מנוחה, טאכיפנאי, רגישות ביטנית דיפוזית, לשון יבשה ומילוי קפילרי מארך, חיתול שהחלף לפני 4 שעות עדיין יבש. מהו השלב הבא בטיפול?

- א. מתן טיפול בתמיסת Oral Rehydration.
- ב. שתיה מרובה והימנעות ממוצרי חלב.
- ג. מתן עירוי נוזלים תוך ורידי עם Loperamide(Immodium).
- ד. מתן טיפול ב-Azythromycin (Azenil) למשך 3 ימים.

103. בת 42, מתלוננת על שיעול חזק וליחה בהירה. שמה לב למספר פסי דם בליחה (Blood Streaks). בתשאול – אינה מעשנת, בריאה בד"כ, עובדת כמורה בבית ספר יסודי. בשלושת הימים האחרונים חום עד 38 מעלות צלזיוס, מלווה בנזלת, שיעול ליחתי וחולשה. זהו אירוע ראשון של דם בשיעול. בבדיקה – דמעת, נזלת, רירית נזאלית היפרמית, אודם בלוע ללא תפליטים. אין ממצא ריאתי בהאזנה. לב - קולות סדירים. מהו הצעד הבא המתאים ביותר?

- א. כיח לציטולוגיה.
- ב. ברונכוסקופיה סיב אופטי.
- ג. כיח לתרביית.
- ד. טיפול סימפטומטי ומעקב.

104. בן 50, לא מעשן, אובחן לפני יומיים עם ממאירות בראה ימנית עם גרורות לעמוד שדרה. הגיע למרפאה מבקש לראות את הרופא. האחות מכניסה אותו לחדר והוא מתחיל לבכות שלא מגיעה לו האבחנה הזו, למה זה קרה לו הוא תמיד שמר על אורח חיים בריא, בחיים לא עישן סיגריה. לפי מודל קוברלר רוס (Kubler-Ross Model) באיזה שלב נמצא המטופל?

- א. הכחשה.
- ב. כעס.
- ג. משא ומתן.
- ד. דכאון.

105. בן 10 סובל מזה שבועיים מכאב בעקב, גובר בעת פעילות במיוחד ריצה או קפיצה ומוקל במנוחה. החל לאחרונה חוג כדורסל. בבדיקתו – רגישות בחיבור גיד אכילס לעקב בביצוע דורסיפלקסיה של כף הרגל. צילום כף הרגל והעקב תקינים. מהי האבחנה יסבירה ביותר?

- א. Calcaneal stress fracture.
- ב. Plantar fasciitis.
- ג. Sever's disease.
- ד. Tarsal tunnel syndrome.

106. מהי ההמלצה לטיפול ב-Metformin למניעת התפתחות סוכרת בחולים עם Pre-Diabetes?

- א. הפחתת משקל ופעילות גופנית סדירה פחות יעילה מטיפול תרופתי.
- ב. Metformin (Glucophage) יעיל יותר באנשים מעל גיל 60.
- ג. הטיפול לא מומלץ לנשים עם Gestational Diabetes בעברן.
- ד. במטופל עם BMI מעל 35, המוגלובין A1C מעל 6.0% יש לשקול טיפול בה.

107. בת 28, ללא ילדים, נשאית למוטציה ב-BRCA2 שהתגלתה לאחר שאימה חלתה בסרטן שחלה בגיל 50. מהו הטיפול המתאים ביותר להפחתת הסיכון לסרטן השחלה במטופלת זו?

- א. ניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות עד גיל 50.
- ב. שימוש בגלולות משולבות, וניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות עד גיל 40.
- ג. הרחבת הבירור הגנטי לקביעת דרגת הסיכון לסרטן שחלה ובהתאם לתוצאה קביעת תזמון של ניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות.
- ד. ניתוח לכריתת שחלות וחצוצרות כ-5 שנים לפני גיל האבחנה של האם.

108. מהו חלק ממעקב רוטיני אחר חולה מבוגר עם אי ספיקת כליות כרונית?

- א. ספירת דם ומבדלת פעם בשנה.
- ב. ALT, AST, PHOS, ALK פעם אחת כבסיס.
- ג. רמת אריתרופואטין פעם בשנה.
- ד. רמת ACE פעם בשנה.

109. באיזה מהמצבים הבאים מבחן מאמץ הוא הבדיקה המועדפת להמשך הבירור?

- א. בן 43, אסימפטומטי, ללא גורמי סיכון, מעוניין בבדיקת סקירה עקב דאגות בריאות.
- ב. בת 50 עם גורמי סיכון למחלת לב, מתלוננת על דקירות בחזה בחצי שנה אחרונה ללא קשר ברור למאמץ. לפני שנתיים עברה מבחן מאמץ שהראה צניחות ST-T עמוקות חשודות לאיסכמיה לכן בוצע בהמשך מיפוי טליום שפורש כתקין.
- ג. בת 63, לאחר אוטם שריר הלב לפני 3 שנים עם הכנסת תומכן לעורק PROX LAD, מאז אסימפטומטית עד לפני שבועיים. בשבועיים אחרונים 4 אירועים של כאבים שורפים בחזה בזמן הליכה חולפים תוך 5 דקות במנוחה, אירוע אחרון של כאבים לפני יומיים הופיע במנוחה.
- ד. בן 46, לאחר אוטם שריר הלב עם הכנסת תומכן לעורק RCA לפני חודש, מרגיש טוב, ללא הגבלה בפעילות יום יומית, מבקש להעריך אפשרות של חזרה לעבודה פיזית.

110. בן 8 שנים, בריא בד"כ, סובל מהרטבת לילה. במהלך היום דחיפות במתן שתן ולפעמים בריחה של שתן. יציאות תקינות. מעולם לא נגמל לחלוטין. האב מדווח שסבל גם הוא מהרטבת לילה בילדות עד גיל 9. בדיקה גופנית תקינה, שתן כללית ותרבית תקין. מה הטיפול המועדף במקרה זה?

- א. פעמונית.
- ב. Minirin (Desmopressin).
- ג. Novitropan (Oxybutynin).
- ד. Tofranil (Imipramine).

111. על פי כוח המשימה הישראלי אילו מהבאים מומלץ על פי ראיות כבדיקת סקר לכלל המטופלים (גברים ונשים) בגילאי 65 ומעלה?

- א. סקירה תקופתית של מכלול הטיפול התרופתי.
- ב. סקירה לאיתור שתיית יתר של אלכוהול.
- ג. בדיקת סקר לחדות הראיה פעם בשנה.
- ד. בדיקת סקר לאיתור ירידה בשמיעה.

112. בן 82, מרותק לביתו עקב מחלת אלצהיימר, MMSE 8/30. ברקע – יתר לחץ דם. מקבל טיפול תרופתי ב-Cardiloc (Bisoprolol) ו-Spasmex (Trospium chloride). משפחתו מתלוננת על אירועים של אי שקט מוגבר לאורך היום והעדר שינה בלילה.

בבדיקתו: לחץ דם 120/70 מ"מ"כ, ללא ממצאים חריגים.

מהו הטיפול המומלץ ביותר בשלב זה?

א. מתן Bondormin (Brotizolam) לשעות הלילה.

ב. התחלת טיפול ב-Memorit (Donepezil).

ג. הפחתה הדרגתית בטיפול ב-Spasmex וב-Cardiloc.

ד. התחלת טיפול ב-Clopixol (Zuclopenthixol).

113. בן 60, BMI 30, ברקע יל"ד ומחלת לב אסכמית. עקב נחירות וישנוניות יומית ביצע בדיקת שינה, ואובחן כסובל מדום נשימה בשינה בדרגת חומרה קשה.

מהן ההמלצות לגבי הטיפול המתאים עבורו?

א. הטיפול בהתקן דנטלי שקול ביעילותו ל-CPAP.

ב. טיפול ב-CPAP במקרה זה צפוי להפחית אריתמיה.

ג. מומלץ לישון על הגב בכדי להפחית אירועי דום נשימה.

ד. ניתוח Uvulo Palato Pharyngoplasty הוא פתרון מוחלט לבעיה.

114. בן 75, סובל מיתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית והגדלה שפירה של הערמונית. מטופל באספירין (Micropirin), Normalol (Atenolol), Omnic (Tamsulin) ו-Tritace (Ramipril). מועמד לניתוח קטרקט.

איזה טיפול תרופתי יש להפסיק לפני הניתוח?

א. אספירין (Micropirin).

ב. Omnic (Tamsulin).

ג. Normalol (Atenolol).

ד. אין צורך בהפסקת טיפול תרופתי.

115. בן 50 מתלונן על כאבים בזמן יציאה מזה 5 ימים. בבדיקת PR נמצא הממצא הבא:



מהו הטיפול המתאים היותר?

- א. מתן סיבים תזונתיים.
- ב. מריחת משחת ניפדיפין 3%
- ג. ניקוז ניתוחי.
- ד. ביופידבק.

116. תינוק בן 4 חודשים הניזון מהנקה בלבד, בריא עד כה ומחוסן כפי גילו. האמא מתארת כי התינוק בוכה הרבה, בעיקר לאחר שאוכל, פולט הרבה, מתעורר לעיתים קרובות בלילה בבכי. בבדיקה – התינוק חיוני, עולה היטב במשקל, ללא ממצאים חריגים. מהי ההמלצה הנכונה ביותר למצב זה?

- א. השכבה על הבטן בשינה.
- ב. הימנעות של האם מחלב פרה.
- ג. הורדת תדירות הנקות.
- ד. מתן Motilium (Domperidone) לפני כל ארוחה.

117. בת 16 בריאה ברקע, מחזור סדיר מגיל 13. מציינת הפסקת הווסת מזה 4 חודשים. מצליחה בביה"ס בלימודים ומבחינה חברתית. שחקנית בקבוצת כדורסל תחרותית. שוללת אקנה/כאבי פרקים/תפרחת/הפרעות ראייה או שינוי ביציאות/ דימום/הפרשה נרתיקית.

BMI באחוזון 10 (בעבר הייתה באחוזון 50), סימני התבגרות תקינים לפי Tanner stages, ללא ממצאים חריגים נוספים בבדיקה.

במעבדה: ספירת דם, כימית תקינות, רמות FSH, LH, טסטוסטרון, TSH ופרולקטין תקינות. מה ההמלצה הטיפולית הסבירה ביותר בשלב זה למטופלת?

- א. טיפול הורמונלי באמצעות תכשיר מכיל אסטרוגן בלבד.
- ב. טיפול הורמונלי באמצעות שילוב אסטרוגן + פרוגסטרון.
- ג. הקפדה על תזונה מסודרת עם intake קלורי מספק והפחתת פעילות גופנית.
- ד. הקפדה על פעילות גופנית רבה ואכילה דלת פחמימות ושומנים.

118. בן 58, התגלה כעת יתר ל"ד חדש. מפחד מטיפול תרופתי עקב חשש מפגיעה בתפקוד המיני. איזו תרופה ניתן לתת לו שלא תגרום לפגיעה בתפקוד המיני?

- א. Norvasc (Amlodipine)
- ב. Normiten (Atenolol)
- ג. Normopresan (Clonidine HCl)
- ד. Tritace (Ramipril)

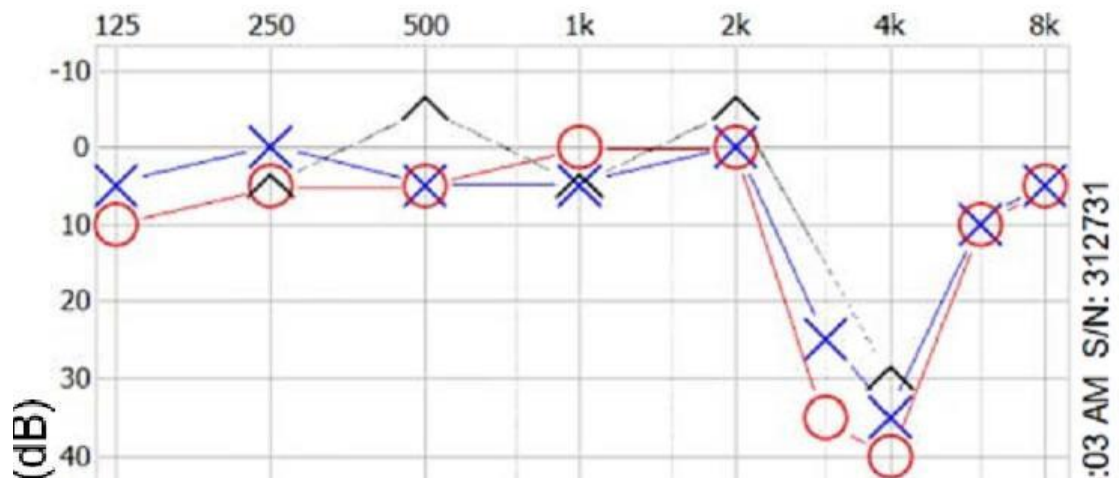
119. בן 14, סבל בשנה האחרונה מארבעה אירועים של Acute Tonsillitis. משטח הגרון היה חיובי ל-Strep. Group A בכל המקרים. בין האירועים משטח גרון שלילי. בני המשפחה נבדקו ונמצאה נשאות לסטרפטוקוקים אצל אחיו בן 8. מהו הטיפול המומלץ?

- א. טיפול אנטיביוטי מניעתי לחצי שנה לאח הגדול, אין צורך בטיפול באח הצעיר.
- ב. מתן Clindamycin (Dalagis) לאח הצעיר בלבד, ללא טיפול באח הגדול.
- ג. בצוע Tonsillectomy לאח הגדול, וטיפול ב-Rafapen לאח הצעיר.
- ד. מתן טיפול ב-Moxypen (Amoxicillin) לשבוע ימים לאח הצעיר בלבד.

120. בן 6 שנים, בריא בד"כ, סובל מאירועים חוזרים של בהייה עם מצמוץ בעיניים אשר נמשכים מספר שניות. בזמן האירוע הילד אינו מגיב לקריאת שמו ואחריהם ממשיך בעיסוקיו כרגיל אך לא זוכר את האירוע. מה יש להסביר להריו לגבי מצבו?

- א. לרוב חולף בחיים הבוגרים.
- ב. לא נדרש טיפול תרופתי.
- ג. לרוב יש Aura מקדימה את הפרקוס.
- ד. זוהי אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי.

121. מוצגת בפניך האודיומטריה הבאה:



איזה תיאור קליני מתאים לתרשים המוצג?

- א. בת 45, אובדן שמיעה חד צדדי לאחר חבלה לאוזן.
- ב. בן 50, לשעבר שרות צבאי בתותחנים.
- ג. בן 5, נוזלים מרובים מאחורי התופיות דו צדדי.
- ד. בת 80, ירידת שמיעה מימין, מבחן וובר נוטה לשמאל.

122. בת 50 הסובלת מפרפור עליות ומטופלת באספירין מתלוננת על כאב בטן עז ביותר, פתאומי שהחל לפני 3 שעות, ללא תלונות נוספות. בדיקתה הגופנית תקינה.
מה הברור המתאים ביותר?

- א. CT אנגיו דחוף.
- ב. צילום בטן סקירה.
- ג. תבחין צואה לנוכחות הליקובקטר פילורי.
- ד. בדיקת על שמע (US) של הבטן העליונה.

123. מה מהבאים נכון לגבי ירידה בחשק מיני באישה hypoactive sexual desire disorder?

- א. ניתן לטפל על ידי מתן סיסטמי/מקומי של אסטרוגן.
- ב. טיפול בטסטוסטרון יכול לשפר חשק מיני אך לא מאושר FDA.
- ג. SSRIs במינון נמוך הוכחו כיעילים.
- ד. אף טיפול תרופתי לא הוכח כיעיל, יש להציג בפני האשה טיפולים לא תרופתיים.

124. בת 3 שנים, סובלת משינויים ביציאות, לעיתים רכות ולעיתים עצירות. במעקב גדילה ניכר כי החל מגיל חצי שנה יש ירידה בעקומות המשקל והגובה.

משקל ירד מאחזון 30 לאחזון 5, והגובה מאחזון 30 לאחזון 3.
במעבדה –המוגלובין 9.8 גרם%, MCV 75, רמת פריטין פחות מ-8.
סוכר בצום 82 מג%.
Anti tTG2 (trans Glutaminase) (IgA) – 92 u/mL (normal 0-5 u/mL).
Total IgA – תקין.

מה השלב הבא הדרוש לאבחון המחלה ממנה סובלת הילדה?

- א. הפניה לייעוץ גסטרואנטרולוגית לצורך ביצוע גסטרוסקופיה.
- ב. בדיקת נוגדי anti Gliadin ab's IgG + IgA.
- ג. יש מספיק נתונים לביסוס האבחנה ללא בירור נוסף.
- ד. בדיקת נוגדי EMA - Endomesial IgA ab's ובדיקת HLA – DQ8/DQ2.

125. את מי מהמטופלים הבאים עם נקע בקרסול יש צורך לשלוח לצילום לפי חוקי OTTAWA?

- א. בן 45 עם כאב באיזור המלאולוס המדיאלי ורגישות במישוש קצה המלאולוס.
- ב. בת 40 שיכלה לדרוך בזמן הפגיעה אך כעת לא יכולה לדרוך.
- ג. בת 50 עם כאב במלאולוס הלטרלי והמדיאלי.
- ד. בן 50 עם כאב ונפיחות באיזור המלאולוס הלטרלי.

126. בת 48, מזה חודשיים נפיחות, כאבים והגבלה בתנועה בכפות הידיים, מצורפת התמונה. במעבדה Anti-Citrullinated Peptide Antibodies מוגברים.



מהן ההמלצות לטיפול במחלה?

- א. מומלץ להתחיל טיפול ב-Methotrexate סמוך לאבחנה, התרופה הוכחה כמפחיתה תחלואה קרדיווסקולרית.
- ב. טיפול ב-DMARD, COX I NSAID אינו מומלץ עקב תופעות לוואי קרדיו-וסקולריות.
- ג. מומלץ להפסיק טיפול במטוטרקסט ולעברו לטיפול ב-Plaquenil במטופלים עם מחלה קשה.
- ד. חולה שמטופל ב-anti-TNF יש לחנן ב-Pneumovax, Zostavax ושפעת עונתית.

127. בת 25, מתלוננת מדי חודש על שבוע של עצבנות, שינויי מצב רוח, התפרצויות, עייפות, חולשה, כאבי פרקים ותחושת תפיחות בטנית בשנה האחרונה. התסמינים משתפרים בהדרגה עד כדי היעלמות למשך כשבועיים עד אשר שוב חווה גל של תסמינים בעלי אופי דומה ולאחריהם רזולוציה מלאה. ברקע – בריאה, ללא טיפול תרופתי קבוע, לא מעשנת, לא משתמשת באלכוהול/סמים. מהו הטיפול התסמיני המומלץ ביותר לימים בהם מרגישה רע?

- א. Wellbutrine (Bupropion) 150 mg פעם 1 ביום.
- ב. Sertraline (Serenada) 50 mg פעם 1 ביום.
- ג. Ibuprofen (Adex forte) 400 mg 3 פעמים ביום.
- ד. Alprazolam (Alpralid) 0.25 mg 2 פעמים ביום.

128. מה ההנחיות הישראליות לסקירת DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) בילודים בריאים ללא גורמי סיכון?

- א. בדיקה קלינית בלבד.
- ב. בדיקת ילוד ובדיקה התפתחותית בגיל 6 שבועות.
- ג. ביצוע אולטאסאונד (US) למפרקי הירכיים.
- ד. אין המלצה על בדיקת סקר לילודים ללא גורמי סיכון.

129. בן 80, ברקע - יתר לחץ דם וסוכרת מאוזנים תרופתית. מתלונן על ירידה בחדות הראיה שאינה משתפרת על ידי משקפיים. בבדיקת פונדוס מתוארים drusen. בשימוש ב-Amsler Grid המטופל התלונן שהקווים לא נראים ישרים. מהי משמעות התלונה המתוארת?

- א. Hypertensive Retinopathy.
- ב. התפתחות גלאוקומה.
- ג. דימום בזגוגית (Vitreous).
- ד. התפתחות נוון רשתית "רטוב".

130. בת 40, ברקע אפילפסיה מטופלת עם Tegretol (Carbamazepine). מתייצגת עם הממצא העורי הבא:



איזו בדיקה יש לבצע כעת?

א. TSH

ב. רמת Carbamazepine.

ג. ALT AST

ד. FSH LH

131. בן 6 שנים, מזה שלושה ימים מסרב ללכת. באנמנזה ללא חום, לא נחבל או נפצע, לא נעקץ נדקר או ננשך, ללא מגע עם חתולים, ללא חשיפה למוצרי חלב לא מפוסטרים. בבדיקתך: מדדים חיוניים תקינים, אינו דורך על רגל ימין, רגישות ממוקדת במישוש עצם השוק. מי מהיגדים הבאים לגבי הברור נכון ביותר?

א. צפויה צמיחה של המחולל בכ- 70% מתרביות הדם.

ב. מיפוי הוא הבדיקה הרגישה ביותר.

ג. בדיקת MRI היא הבדיקה הרגישה ביותר.

ד. בדיקת CRP תקינה שוללת את האבחנה ובקורלציה ישירה לנזק מפרקי.

132. מה מהבאים הוא קריטריון מחייב לאבחנה של Polymyalgia Rheumatica?

א. תגובה מהירה לטיפול בסטרואידים.

ב. כאב בשתי הכתפיים.

ג. גיל מעל 40.

ד. Rheumatoid Factor או Anti-CCP חיוביים.

133. בן 43, בריא בד"כ. מתלונן על סחרחורת סיבובית ובחילות שנמשכות ברצף מזה מספר ימים. ללא ירידה בשמיעה. לאחרונה סבל מסימפטומים ויראליים. שולל כאבי ראש ותלונות נירולוגיות אחרות. בבדיקתו - נוטה ליפול לימין, ניסגמוס הוריזונטלי לשמאל, ספונטני. בדיקת Dix Hallpike שלילית.

מהו המהלך הצפוי בהתחשב באבחנה הסבירה ביותר?

- א. פרוגנוזה לא טובה, גם לאחר טיפול פולשני.
- ב. בהמשך תתפתח ירידה בשמיעה במרבית המקרים.
- ג. טיפול אנטי-ויראלי צפוי לשפר מהלך המחלה.
- ד. צפוי שההפרעה בשיווי המשקל תמשך מספר חודשים.

134. באיזה המטופלות/ים הבאים/ת עם כפל ראייה חדש MRI מוח הכרחי לאישוש האבחנה הסבירה ביותר?

- א. בת 25, ברקע מחלת גרייבס לא מאוזנת.
- ב. בת 32, בשנה האחרונה אירועים חוזרים של פרסטזיות.
- ג. בת 72, קושי בנהיגה בלילה וקריאת אותיות קטנות.
- ד. בן 55, ידוע על רטינופתיה סכרתית וסכרת לא מאוזנת, מספר גם על קוצר ראייה.

135. באיזה מהמצבים הבאים נדרש להתחיל טיפול בהקדם?

- א. Internal femoral torsion בילדה בת 4.
- ב. Internal tibial torsion בילדה בת שנה וחצי.
- ג. Congenital Club foot.
- ד. Congenital Metatarsus adductus.

136. בת 30, מיששה גוש בשד ימני. המטופלת אם לשלושה, הניקה במצטבר שנה וחצי. ללא סיפור משפחתי של סרטן השד. בבדיקתה נמוש גוש נייד, די שטחי, עם גבולות סדירים, עם מרקם אלסטי, ציסטי. אין רגישות במישוש. עור השדיים ופטמות תקינים. ללא בלוטות לימפה מוגדלות בבתי השחי. מהו השלב הבא בבירור?

- א. ניקור אבחנתי (FNA)
- ב. US שדיים ובתי השחי
- ג. לא דרוש המשך בירור
- ד. ממוגרפיה

137. בן 8, בריא ומחוסן כפי גילו. אביו מספר כי בחודש האחרון יש לו נזלת שקופה ועיטושים רבים ומעט גירוי בעיניים, ללא חום או שיעול. היו תקופות דומות גם בעבר. לאחותו הגדולה יש אסתמה והפרעת קשב וריכוז. הילד מתלונן כי הנזלת והעיטושים מפריעים לו בפעילות שגרה. מה נכון לגבי אפשרויות הטיפול במצבו?

- א. אנטיהיסטמין פומי יכול לסייע לתסמינים של עיטוש ונזלת אך לא לתסמינים עיניים.
- ב. תרסיס סטרואידלי נזאלי יכול לסייע לתסמינים של עיטוש ונזלת אך לא לתסמינים עיניים.
- ג. Leukotriene-modifying agents יעילים מאוד לנזלת אלרגית אך בשל עלותם הגבוהה מיועדים רק כטיפול קו שני למקרים קשים.
- ד. טיפול באימונתרפיה למצבו יעיל ועשוי למנוע התפתחות אסתמה.

138. בן 50, בדרך כלל בריא, מתלונן על שיעול ליחתי מזה כחודש וחצי, מלווה בחום ותשישות. ברקע – אינו מעשן, חזר משליחות באפריקה לפני שנה. בבדיקה גופנית: חיוור, קצב נשימות 28 לדקה, בבדיקת החזה עמימות בניקוש ריאה שמאל עליונה. מהו הצעד הבא המתאים ביותר בשלב זה?

- א. טיפול אמפירי ב-Augmentin.
- ב. תרביית כיח.
- ג. צילום חזה.
- ד. כיח לציטולוגיה.

139. לפניך מספר מקרים קליניים.

מהו המקרה שמתאים לתוצאות בדיקת ההדמיה?

- א. בת 74, בריאה, פונה בשל הליכה על בסיס רחב, אירוע של בלבול בו לא זכרה איפה היא נמצאת. האירוע חלף לאחר 45 דקות. בהדמיה נמצא היצרות של 90% בעורק Vertebrobasilar משמאל.
- ב. בן 73, ברקע סכרת, פנה בשל חולשה ביד ורגל ימין שנמשכו שעתיים וחלפו. באקו לב נמצא PFO (Patent Foramen Ovale) בגודל של 0.8 מ"מ.
- ג. בת 62, לוקה ביתר לחץ דם, פונה בשל סחרחורת ועיוורון בשתי העיניים, אי יציבות בהליכה שחלפה לאחר שעה. בבדיקת דופלקס נמצא היצרות של 85% בקרוטיד שמאל.
- ד. בן 65, מעשן, פונה בשל עיוורון בעין ימין שנמשך למספר דקות וחלף. בבדיקת Trans Cranial Doppler נמצאה היצרות של 90% ב-Vertebrobasilar artery.

140. באיזה מקרה רופא מטפל רשאי לא למסור מידע רפואי למטופל?

- א. המידע מסכן את בטחונו האישי של הרופא.
- ב. הרופא מחויב למסירת מידע למטופל בכל מצב.
- ג. המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של בן משפחה של המטופל.
- ד. המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל, ובאישור של ועדת אתיקה.

בשאלות הבאות התשובה היא על דרך השלילה

141. בת 45 מתלוננת על כאב באצבעות, בעיקר בחשיפה לקור, מלווה בממצאים הבאים:



איזו מהאבחנות לא מתאימה למצבה?

- א. Scleroderma
- ב. Systemic Lupus Erythematosus
- ג. Sjögren Syndrome
- ד. Psoriatic Arthritis

142. בת 49 פונה עם כאבים בצוואר מזה כחודש.
באיזה מהמקרים הבאים אין צורך בביצוע צילום כעת?

- א. ברקע ankylosing spondylitis.
- ב. ברקע תסמונת דאון, בתפקוד גבוה.
- ג. ברקע מנופאוזה מזה שנתיים, ללא טיפול תרופתי קבוע.
- ד. ברקע rheumatoid arthritis מטופלת במטוטרקסט.

143. לפניך תיאור של 4 מטופלים עם רטינופטיה סוכרתית.

איזו הסתמנות לא תואמת את ממצאי הבדיקה?

- א. בת 70, סוכרת סוג 2 מזה 25 שנה. HbA1C 9%. מתלוננת על הופעה פתאומית של עין אדומה וכואבת. בבדיקה – נאווסקולריזציה.
- ב. בת 70, סוכרת סוג 2 10 שנים. מתלוננת על ירידה בראייה מרכזית. בבדיקה - cotton wool ללא בצקת.
- ג. בת 30, סוכרת סוג 1 מזה 15 שנה. מתלוננת על אובדן ראייה פתאומי ללא כאב. בבדיקה - Vitreous Hemorrhage.
- ד. בן 65, סוכרת סוג 2 מזה 15 שנה. HbA1C 8%, LDL-130, לחץ דם 150/95. מתלונן על אובדן ראייה הדרגתי. בבדיקה - Macular Edema.

144. מה מהבאים לא מהווה הורייט נגדל לטיפול בגלולות משולבות בבת 38?

- א. עישון פעיל של 18 סיגריות ליום.
- ב. אישה 4 שבועות לאחר לידה נרתיקית, אינה מניקה.
- ג. אנמנזה של אירוע חד פעמי של דמם לאחר יחסי מין.
- ד. סרטן שד אצל אמה של המטופלת בגיל 51, בירור גנטי תקין.

145. בן 42, מוכר היטב לרופא המשפחה סובל זה תקופה מ-Major Depressive Episode. הוא ששוחרר

ממיון אתמול בערב לאחר ניסיון אובדני. במכתב השחרור צוין "כעת ללא מסוכנות מידית, אין אינדיקציה לאשפוז, להמשך טיפול במסגרת בריאות הנפש בקהילה".

מה אינו נכון לגבי המשך הטיפול?

- א. מומלץ לצמצם מרשמי תרופות, לרשום תרופות קבועות ל- 30 ימים בלבד ולבקש מבני משפחה לפקח על תרופות וכלי נשק הנמצאים בבית.
- ב. חוזה למניעת אובדנות ("suicide contract"), בו המטופל מתחייב שלא לפגוע בעצמו, הוכח כיעיל למניעת ניסיון אובדני נוסף.
- ג. Crisis planning המשלב שיחה עם המטופל על מיומנויות התמודדות עם משבר וחיבור לגורמי תמיכה בקהילה.
- ד. בקרב מטופלים עם דיכאון מג'ורי ואובדנות מתמשכת ניתן להתחיל טיפול בליתיום לצמצום אובדנות.

146. בן 24, איש מחשבים, לאחרונה החל באימוני ריצה. מזה כחודש ימים סובל מכאבים בכף רגל שמאל. הכאב חמור בקימה בבוקר ומוקל לאחר מספר צעדים, מוחמר שוב לקראת הערב. מה **לא נכון** לגבי הטיפול בבעיה?

- א. הזרקה מקומית של סטרואידים יכולה לגרום לאטרופיה של כרית השומן בכף הרגל.
- ב. תרגילי מתיחה של גיד אכילס יכולים להקל על הכאבים.
- ג. הזרקת PRP (Platelet Rich Plasma) גורמת להקלה קצרת טווח בלבד.
- ד. שימוש בסד לילה השומר על Plantar Flexion של כף הרגל.

147. מטופל סובל מסרטן מעי גס גרורתי בשלב סופני. מבקש איזון כאב על ידי טיפול באופיאטים. (Opiate). בהתייחס לתופעות הלוואי של התרופות, **מה אינו נכון?**

- א. עצירות – יש לתת טיפול מניעתי לדוגמא ב- Laxadine (Bisacodyl Sodium) עם התחלת הטיפול באופיאטים.
- ב. דיכוי נשימתי – יש להימנע ממתן תכשירים אופיאטים למטופלים עם קושי נשימתי.
- ג. מיוקלונוס – העברה לאופיאט אחר במינון מופחת במידה והמטופל סובל מהתופעה.
- ד. בחילות – טיפול ב- Zofran (Ondansetron) או Pramin (Metoclopramine).

148. מה מהבאים **שגוי** לגבי בירור שימוש לא בריא באלכוהול בקרב מטופלים?

- א. "כמה פעמים בשנה האחרונה שתית באותו יום 4 משקאות אלכוהול (לנשים) / 5 משקאות אלכוהול (לגברים)?" הינה שאלת הסקר המומלצת.
- ב. שאלון CAGE הינו בעל רגישות טובה, והוא שאלון מומלץ לשימוש בקווים המנחים בארץ ובעולם.
- ג. בהנחיות הישראליות קיים דגש על תשאול שימוש באלכוהול בקרב נשים הרות ואלו המתכננות הריון.
- ד. לשאלוני AUDIT-C ו-SASQ רגישות וסגוליות דומות באיתור שימוש לא בריא באלכוהול.

149. בן 35 עם BMI 32 מבקש להיוועץ לגבי שיטות להרזיה.

איזה היגד מהבאים לגבי ירידה במשקל לא נכון?

- א. כל דיאטה עם הגבלה קלוריות שצריכת הקלוריות פחותה מההוצאה הקלורית תוביל לירידה במשקל.
- ב. שינויים בסביבת העבודה הוכחו כעוזרים לירידה במשקל.
- ג. ניתוח בריאטרי מוריד את ה-all-cause mortality.
- ד. שימוש ב-Liraglutide מעלה את הסיכון לסרטן של ה-Parathyroid.

150. מה אינו חלק מהטיפול במטופל עם Multiple Myeloma?

- א. טיפול ב-Bisphosphonates נדרש בחולים אלו.
- ב. יש צורך במניעת VTE על ידי DOAC (Direct Oral Anti-Coagulants) ב-4-6 חודשים מהאבחנה.
- ג. השתלת מח עצם עצמית (אוטולוגית) מאריכה את השרידות בכשנה.
- ד. השתלת מח עצם עצמית מומלצת גם אם טיפול כימותרפי הדגים יעילות.

בהצלחה